

TEMA 46



LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS MAYORES EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: INTERVENCIÓN EN LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y NECESIDAD DE CUIDADOS.

MALTRATO EN LAS PERSONAS MAYORES.

PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS.

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La atención social a las personas mayores en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.	
2.- Maltrato en las personas mayores.	
2.1.- Pautas de detección. 2.2.- Tipos de maltrato, grados y signos de alerta. 2.3.- Herramientas de detección. 2.4.- Intervención en malos tratos.	
3.- Fomento del envejecimiento activo y participativo. Programas, servicios y recursos.	
3.1.- Participación y mucho más. 3.2.- Centros Municipales de Mayores con Servicios Integrados. 3.3.- Ejercicio como exponente de actividad social y saludable. 3.4.- Vivienda y convivencia. 3.5.- Prevención de la soledad. 3.6.- Sensibilización.	
4.- Personas mayores que necesitan cuidados. Programas, servicios y recursos.	
4.1.- Envejecer en casa. 4.2.- Servicios domiciliarios para personas mayores y personas con discapacidad. 4.3.- Centros de Día. 4.4.- Atención a quienes cuidan. 4.5.- Servicios residenciales. 4.6.- Situaciones de dependencia. 4.7.- Mayores vulnerables.	

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

0.- INTRODUCCIÓN.

El envejecimiento y la evolución de la dependencia es un proceso evolutivo de las edades que modifica las relaciones entre las distintas generaciones, lo cual supone un gran reto que debemos gestionar para afrontar con garantías el incremento del bienestar social de este colectivo. El proceso de envejecimiento ha ido cambiando en los últimos años, de hecho, a finales de los años 60 ya empezó a reducirse la tasa de fecundidad, lo cual ha tenido efectos importantes dentro del contexto personal, familiar, económico y social actual.

La sociedad actual ensalza la juventud por su relación con la belleza y la salud, y ve como negativo el envejecimiento ya que con él se van perdiendo algunos de estos atractivos. La sociedad crea sus propios estereotipos y son muchos los que hacen referencia a los mayores: son todos muy parecidos, son dependientes, están deprimidos, aislados socialmente, son de difícil trato, no son productivos y no tienen interés por aprender nuevas habilidades. Estas creencias se encuentran arraigadas tanto en la población joven como en la población mayor según las investigaciones realizadas por los psicólogos Montañés, Latorre y Chasteen.

Las personas mayores forman un colectivo muy diverso y la mayoría envejece de forma satisfactoria. Son muchos los que viven con su familia, mantienen contacto cercano con otros miembros de la misma; o viven de forma independiente no necesitando ayuda para realizar las actividades de la vida diaria. Se relacionan con amigos, vecinos y saben adaptarse a los desafíos de la vida con éxito.

Como no puede ser de otra manera, los mayores al igual que el resto de los ciudadanos, tienen derecho a vivir en entornos donde sean tratados con respeto. Como sujetos de pleno derecho el trato inadecuado es una incuestionable violación a tales derechos. Es fundamental fomentar una **Cultura de Buen Trato** entre todos los miembros de la sociedad e inculcarlo a través de la educación desde los primeros momentos de la vida.

El **Buen Trato** implica un reconocimiento de las posibilidades físicas y emocionales de los demás, empatía que permita ponernos en el lugar del otro, posibilidad de interaccionar positivamente, comunicación efectiva que permita a través del lenguaje verbal y no verbal conocer y expresar las necesidades y deseos nuestros y de los demás, y negociación para ser capaces de resolver los conflictos que aparecen en el día a día.

1.- LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS MAYORES EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

La atención social a las personas mayores es asumida, dentro del **Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad** por la **Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad no Deseada.** Las competencias que asume el Ayuntamiento de Madrid tienen como misión contribuir al **bienestar de las personas mayores, a su autonomía y a su integración social, mejorando su calidad de vida**. Abarca desde las más autónomas hasta las más vulnerables o con necesidad de cuidados que deberán recibir especial atención. Su visión es el deseo de ser una organización de referencia, para las personas mayores, los profesionales y la ciudadanía en general.

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

La actual **Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad no Deseada** asume las siguientes competencias:

1. Promover cualesquiera actuaciones tendentes a favorecer un **envejecimiento generativo y el apoyo a las personas mayores y su red familiar y social**, en las diferentes facetas que comprende su atención integral.

2. Impulsar **políticas públicas de atención a las personas mayores que favorezcan la amigabilidad de la ciudad** con ellas y las sitúen en el centro de las diferentes actuaciones municipales que las incumben.

3. Favorecer la **participación de las personas mayores en la vida social de los barrios y distritos** a cuyo efecto se actualizará y potenciará, entre otras actuaciones, el papel de los actuales **centros municipales de mayores.**

4. Fomentar actuaciones tendentes a **favorecer el trato adecuado hacia las personas mayores**.

5. Impulsar políticas públicas para **prevenir la soledad no deseada en las personas mayores**.

6. Coordinar la intervención de los diferentes servicios municipales implicados con aquellas personas mayores que pudieran encontrarse en **riesgo o situación de maltrato y vulnerabilidad social**, por presentar **situaciones de soledad no deseada, aislamiento, negligencia y/o trato inadecuado**.

7. Diseñar y proponer **programas y servicios para las personas mayores**, en especial los referidos al **mantenimiento de la persona mayor en su propio hogar** todo el tiempo posible y los que tienen por objeto el **apoyo a las familias que las cuidan**.

8. Desarrollar la **política de calidad de aplicación en los servicios y prestaciones de atención a las personas mayores** de la ciudad de Madrid, implantando y evaluando periódicamente los criterios y estándares de calidad conforme a los que aquellos habrán de prestarse; auditando los distintos programas y servicios municipales para personas mayores al tiempo que realizando los correspondientes estudios de satisfacción, opinión e investigación que considere pertinentes respecto a los mismos.

9. **Planificar, dirigir y evaluar los servicios de ayuda a domicilio dispensados a las personas mayores, así como a las personas con discapacidad**.

10. Adoptar cuantas resoluciones resulten pertinentes en relación con los servicios de ayuda a domicilio, en modalidades tales como: **suministro a domicilio de alimentos preparados o servicios análogos, lavado, planchado y repaso de ropa fuera del hogar o productos de apoyo y ayudas técnicas**.

11. Planificar, dirigir y evaluar el servicio de **centros de día para personas mayores**, ya sean estos municipales o privados con plazas financiadas por el Ayuntamiento de Madrid, y centros residenciales.

12. Adoptar cuantas resoluciones resulten pertinentes en relación con los **centros de día para personas mayores, municipales o privados con plazas financiadas por el Ayuntamiento de Madrid, y centros residenciales en los términos previstos en la ordenanza** reguladora de esta materia.

13. Coordinar los servicios de **los centros municipales de mayores**, sin perjuicio de las competencias de gestión que sobre estos centros correspondan a los distritos.

14. Promocionar la **autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia sobre una adecuada coordinación con la Comunidad de Madrid**, competente en la materia, y de acuerdo con la atribución competencial que corresponda al Ayuntamiento de Madrid en cada momento.

15. Diseñar y proponer programas y servicios para el desarrollo de otras **alternativas habitacionales como las viviendas colaborativas o las viviendas compartidas.**

TRUJILLO FORMACIÓN

2.- MALTRATO EN LAS PERSONAS MAYORES.

En el Pleno del **28 de junio de 2.017** se formuló una declaración institucional con motivo del **Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez** (15 de junio).

Esta Declaración planteo como compromiso:

- Condenar todo tipo de maltrato, incluido el ejercido contra las personas mayores, sea cual sea su tipo o severidad.
- Realizar acciones contra los estereotipos sobre la vejez a favor del empoderamiento de las personas mayores, facilitando su implicación en la toma de decisiones de la ciudad.
- Tomar partido en la lucha contra el maltrato mediante acciones de sensibilización y promoción del buen trato.
- Favorecer la formación de sus profesionales al objeto de promover una mayor capacitación para afrontar estas situaciones.
- Disponer de servicios y programas inespecíficos y específicos para el abordaje de los factores de riesgo, contemplando el apoyo a las familias como pilar fundamental.
- Apostar por un protocolo municipal de intervención coordinada ante el maltrato, en el que los servicios sociales y sanitarios compartan los mismos criterios y se complementen.
- Desarrollar un Protocolo de Prevención, Detección y Abordaje del Maltrato a las Personas Mayores en las instituciones municipales que se dedican específicamente a la atención a las mismas.
- Estudiar las áreas de mejora detectadas y establecer alianzas.
- Unirse a la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

En **junio de 2.022** el Ayuntamiento de Madrid publica el documento **"Personas mayores vulnerables que sufren maltrato: Guía de intervención en el ámbito domiciliario".** Esta guía sustituye, tras una profunda revisión, a la Guía que se puso en marcha en el año 2.018. En este sentido incorpora la valoración de factores de riesgo relacionados con el contexto familiar e incorpora la valoración de la **violencia de género** entre los tipos de maltrato ya existentes.

Según la **Declaración de Almería**, fruto de la primera reunión de consenso se considera maltrato a las personas mayores:

*"Cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física, psíquica, así como el principio de autonomía o el resto de los derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente, o percibido subjetivamente con independencia de la intencionalidad o no y del medio donde suceda" (**Declaración de Almería, 1995**).*

En sintonía total con la **reunión de expertos de Toronto**,

*"El maltrato a las personas mayores es un acto único o repetido, o la falta de una acción apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza, que causa daño o angustia a una persona mayor. Puede ser de varias formas: físico, psicológico / emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar negligencia intencional o por omisión" (**Gobierno de Ontario, Toronto, 2002**)*

Bajo este paraguas se ocultan diferentes tipos de maltrato, estrechamente interrelacionados y a menudo simultáneos, como es el caso del maltrato físico, sexual, psicológico, financiero, negligencia, abandono o violación de derechos básicos, sin olvidar que la violencia de género no cesa por cumplir años.

TRUJILLO FORMACIÓN

La literatura sobre el tema sitúa la prevalencia entre un 1% y un 10%, algo que nos indica con claridad que se desconoce la magnitud real. En la actualidad, la recepción de casos de maltrato en la mesa de vulnerabilidad de larga trayectoria puede ofrecernos una idea somera del problema detectado, a sabiendas de que la gran mayoría permanecen ocultos y que los recibidos son en general casos graves. Con estas premisas podemos establecer entre un 11 y un 19% los casos correspondientes a maltrato entre los recibidos en la mesa de vulnerabilidad, con cierta tendencia al alza.

2.1.- PAUTAS DE DETECCIÓN.

Conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a cualquier profesional a tomar las decisiones más apropiadas sobre el maltrato a personas mayores en el ámbito doméstico basándose en herramientas y técnicas propias de la actividad profesional.

DETECCIÓN.

Son múltiples los agentes que pueden hacer detección de malos tratos a personas mayores, tanto formales como los servicios sociales, servicios de apoyo a las personas mayores, servicios de emergencia, programas comunitarios, etc., como informales: familias, vecinos, voluntariado entre otros.

Hay que tener en cuenta que ante cualquier sospecha es imprescindible comunicar esta situación.

Cuando se realiza intervención con personas mayores hay que estar alerta a cualquier signo que haga sospechar una situación de maltrato y si este fuera grave o se conoce un riesgo vital para la persona, es necesario avisar a la policía. Los profesionales tenemos la obligación, no solo moral, sino también legal de comunicarlo.

FACTORES DE RIESGO.

La literatura nos indica que la sospecha de maltrato se basa en **observaciones sobre la posible "víctima" y la persona "responsable**", así como algunos datos de la **interacción entre ambos y del entorno.**

Existen múltiples escalas o cuestionarios de sospecha, aunque todos ellos han de ser tomados como lo que son, instrumentos de alerta que inducen a una valoración completa. Nunca la aplicación de un instrumento de sospecha nos puede llevar a confirmar un caso de maltrato. Para su confirmación, es necesario realizar una evaluación más pormenorizada que incluya no solo a la persona mayor, sino también a la posible persona responsable del maltrato y al contexto de la situación. Sólo así se puede llegar a confirmar, en su caso, la existencia de maltrato.

En el caso de la víctima, hay que tener presente siempre el grado de dependencia o necesidad de ayuda. Mujer, con limitaciones para la realización de las actividades de la vida diaria, especialmente si existe deterioro cognitivo, constituye el perfil más común, desde un punto de vista excesivamente reduccionista, puesto que la diversidad es enorme.

TRUJILLO FORMACIÓN

FACTORES DE RIESGO.

Víctima.	Responsable de malos tratos.
- Sexo. - Edad. - Presencia de comportamientos provocadores y/o agresivos. - Presencia de deterioro cognitivo. - Mala salud. - Depresión. - Problemas de comunicación. - Dependencia física, mental, económica o social. - Grado de dependencia (salud deficiente, dependencia física y conductual, deterioro cognitivo y conductas de comportamiento alteradas). - Enfermedades crónicas discapacitantes. - Otras características: culpabilización de la situación, lealtad excesiva hace el responsable de los malos tratos, resignación o vergüenza. - Factores asociados a la edad: sentimientos de inferioridad, auto marginación, aislamiento voluntario y de sentimiento de falta de utilidad e importancia, sentimiento de declive, de carga social.	- Sexo. - Inexperiencia. - Presencia de trastornos psicológicos. - Abuso de sustancias y/o drogas. - Percepción del cuidado como una carga. Estrés. - Alto nivel de exigencias de atención al mayor y excesivas demandas de ayuda. - No asunción de la responsabilidad como cuidador. - Otras características: culpar al mayor de su situación, no comprender sus necesidades, etc. - Dependencia económica. - Presencia de sentimientos negativos, como ira u hostilidad. Baja autoestima, poca adaptación a los cambios, rechazo de responsabilidades, impulsión. Pérdida de control. - Estrés por situación social independiente de los cuidados (ausencia de trabajo, enfermedad, problemas económicos, ausencia de proyecto vital…). - Estado de Salud/Enfermedades. - Justificación/minimización de la situación. - Falta de formación y apoyo a la persona cuidadora. - Los cuidados recaen únicamente en la persona cuidadora. - Deterioro cognitivo y/ o enfermedad terminal en el maltratador.

FACTORES DE RIESGO FAMILIARES.

- Tipo de vinculación familiar.
- Ciclo evolutivo familiar.
- Insatisfacción con las relaciones dentro del seno familiar.
- Historia familiar: disfuncionalidad familiar, violencia en el ambiente familiar, anomalía en las relaciones paternofiliales, en la convivencia, divorcios.
- Desgaste de los vínculos intergeneracionales.
- Reducción/ausencia de red de apoyo familiar.

TRUJILLO FORMACIÓN

FACTORES FAMILIARES DEL CONTEXTO.
- Cantidad de ayuda (formal e informal) recibida (los cuidadores que menos ayuda reciben presentan mayor riesgo de maltrato). - Falta de contactos formales y/o informales (aislamiento social). - Vivienda compartida con otras personas, en contra de la voluntad. - Edadismo.

La actuación sobre estos factores, en la medida de lo posible, con los medios disponibles, ha de ser una prioridad en la actuación sobre los malos tratos.

La **sospecha** suele venir por una serie de signos y síntomas en la víctima, la persona supuestamente responsable y la interacción entre ambas.

La activación sobre estos factores con medidas compensadoras ha de ser una prioridad, pues estaremos evitando que se produzcan situaciones de maltrato.

De manera general, en una **valoración inicial en entrevistas o visitas domiciliarias**, se puede considerar que la presunta víctima parece tener miedo de alguna persona, cuando le preguntan no quiere responder o mira a alguien antes de responder, su comportamiento cambia cuando entra o sale de la habitación, manifiesta sentimientos de soledad, dice que no tiene amigos, familia, dinero, medio de transporte, etc., se aprecia baja autoestima: "no sirvo para nada", "aquí estoy molestando", se refiere a alguna persona como una persona "con genio" o frecuentemente "enfadada" o muestra excesivo respeto a alguna persona de su entorno.

En el caso de la presunta persona responsable, es frecuente que padezca un importante nivel de estrés o de sobrecarga, intenta evitar que el/la profesional y la persona mayor hablen en privado, insiste en contestar a las preguntas que se le hacen a la víctima, pone obstáculos para la asistencia socio sanitaria, olvida las citas médicas de la persona mayor, las expectativas hacia la persona mayor no son realistas o no tiene conciencia sobre el proceso "normal" de envejecimiento o carece de formación o capacidad suficiente para cuidarla.

La interacción entre ambas personas puede ser conflictiva, con frecuentes discusiones, insultos, etc. La persona responsable se muestra hostil, enfadada o impaciente durante la visita y la persona mayor está agitada o demasiado tranquila en su presencia. También puede haber conflictos o crisis familiares recientes, incluso puede haber indiferencia mutua, o simplemente cuentan historias incongruentes, contradictorias o extrañas sobre cómo ha ocurrido un determinado hecho.

En el caso de **sospecha de violencia de género**, además de identificar muchos de los factores señalados anteriormente, es necesario contrastar con los indicadores específicos de violencia recogidos en esta guía. Además, hay que tener en cuenta los indicadores comportamentales tanto en el agresor como en la víctima, como por ejemplo las situaciones en las que ella muestre dificultad para tomar decisiones autónomas, mostrarse a la defensiva o en estado de alerta o no tomar la palabra en presencia del agresor. En el caso de este, puede ocurrir que no permita que la mujer acuda sola a una entrevista, impida que se comunique o la interrumpa de manera constante e incluso buscando alianzas con el personal profesional para intentar desacreditar la capacidad de la mujer en relación con diversos asuntos.

Es importante conocer el grado de dependencia de la persona mayor y, en la medida de lo posible, si existe deterioro cognitivo o demencia, ya que:

- **A mayor dependencia, mayor riesgo.**
- **La demencia es un agravante.**
- **El riesgo de sufrir maltrato aumenta con la edad.**
- **Si es mujer, puede tratarse de violencia de género.**

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

2.2.- TIPOS DE MALTRATO, GRADOS Y SIGNOS DE ALERTA.

Hay que tener presente que **generalmente los tipos de maltrato se mezclan e interactúan**, de manera que el maltrato psicológico suele estar presente en casi todos los demás tipos o que la negligencia, en ocasiones, constituye un auténtico maltrato físico. Del mismo modo, una retención ilegal, además de constituir un delito, puede suponer un gran riesgo de lesión física. Igualmente, un maltrato sexual (también delito) es una agresión, aunque se clasifique como tal por la intencionalidad.

Establecer una diferenciación por tipologías del maltrato a personas mayores y su severidad ayuda a sistematizar su análisis. A continuación, se exponen los distintos tipos de maltrato, con las limitaciones expuestas con anterioridad:

- **Negligencia.**
- **Maltrato físico.**
- **Maltrato psicológico.**
- **Violación de derechos básicos.**
- **Maltrato sexual.**
- **Maltrato financiero.**
- **Abandono.**
- **Violencia de género**

NEGLIGENCIA.

Comportamiento nocivo por parte de la persona obligada a cuidar a la persona mayor. Rechazo u omisión de proporcionar lo necesario para cubrir sus necesidades básicas (higiene, medicamentos, comida, recursos...). Puede ser activa, como la falta de cuidados necesarios por parte del cuidador de forma consciente, y pasiva, que se centra en el olvido y abandono (incapacidad de la persona responsable de los cuidados). No solo omisión de proporcionar a la persona mayor lo necesario para cubrir sus necesidades básicas sino también evitar daños que pudiera tener por otros motivos. Se pone en riesgo la seguridad y la salud.

Menos grave	**Grave**	**Muy grave**
El cuidador no apoya en actividades básicas de la vida diaria.	Descuido en el cuidado de la persona mayor, o no dar la atención adecuada por falta de capacidad del cuidador.	Situación que compromete gravemente su salud. Desnutrición y deshidratación severa por falta de alimentación o negación de la misma.

Indicadores.

Menos grave	**Grave**	**Muy grave**
Se detectan indicadores de sobrecarga o incapacidad para el cuidado en el cuidador principal. Presenta un aspecto descuidado o desaliñado, ropa sucia.	No se cambia el absorbente con la frecuencia necesaria. Ausencia de higiene y ropa sucia. Pérdida de peso y malnutrición. Alimentación inadecuada.	El cuidador principal, aunque acepta la intervención, dificulta el desarrollo de servicios de atención para la persona mayor.

TRUJILLO FORMACIÓN

Vivienda descuidada con falta de higiene.	No tiene actualizada la medicación o existe falta de control en la misma. Seguimiento incorrecto de sus patologías. Hospitalizaciones frecuentes	Empeoramiento de enfermedades crónicas por ausencia de cuidados, incumplimiento de tratamiento médico. No realización de cambios posturales necesarios, ni cambios de absorbentes. Desnutrición y deshidratación severa. Extrema delgadez. Úlceras por presión u otra lesión grave y mal atendida. El mayor desprende mal olor (normalmente a orina y heces) y la ropa está sucia, es inadecuada o carece de la misma. Ausencia de higiene corporal y en la ropa de la persona mayor. No existe seguimiento médico. Descompensación por déficit de control en la prescripción de medicamentos. Ausencia de lugar adecuado para dormir o descansar. Suciedad en la vivienda, falta de suministros. Condiciones de vivienda insalubres.

MALTRATO FÍSICO.

Todo tipo de violencia física, aunque no cause lesión: desde los golpes fuertes, al simple arañazo y el pellizco, golpear, abofetear, quemar, confinar a una persona mayor, uso inapropiado de medicación, etc. llevada a cabo por otras personas, de forma intencional, que causa daño o lesión. La negligencia, en ocasiones, también puede considerarse dentro de esta categoría.

Menos grave	**Grave**	**Muy grave**
Agresión sin lesión física (empujón, zarandeo…) OJO: alerta inminente de que se produzca una lesión.	Agresiones reiteradas que no ponen en peligro la vida, pero causan dolor físico y emocional.	Agresión física intencionada con gran violencia que provoca lesiones graves, agresiones en el contexto de violencia de género y doméstica.

TRUJILLO FORMACIÓN

Indicadores.		
Menos grave	**Grave**	**Muy grave**
Verbalización por parte del usuario de que no recibe un trato adecuado. Cambio de actitud de la persona mayor en presencia de cuidadores. Negativa por parte del cuidador a que el anciano reciba visitas.	Enrojecimiento, lesiones menores y hematomas que causan un daño menor. Incoherencia entre mecanismo de movilización y la lesión producida.	Lesiones graves. Sujeciones y restricciones físicas o/y químicas sin prescripción. Marcas de ataduras (no sujeciones). Hematomas de diferente grado y estadio de evolución. Luxaciones (dolor al ser tocado). Fracturas mal consolidadas. Quemaduras sin causa que lo justifique. Alopecia parcheada. Desnutrición y deshidratación. Alimentación forzada y con violencia. La lesión que se observa no se puede explicar por el mecanismo de movilización. Uso inapropiado de medicamentos con intención de causar daño. Demora en la solicitud de atención sanitaria o petición de tratamiento con grave perjuicio para la salud.

MALTRATO PSICOLÓGICO.

Abuso emocional (amenazas, intimidación, humillación, infantilización, actitudes edadistas, insultos...) donde una persona ejerce un poder sobre otra incidiendo sobre la estabilidad emocional.

Menos grave	**Grave**	**Muy grave**
Actitud edadista por parte del cuidador. Escasa escucha sobre deseos o preferencias del mayor, se le ignora, se le culpabiliza. Gritos ocasionales y órdenes bruscas. Actitud machista por parte del cuidador.	Menosprecio, intimidación, manipulación, insultos, acusaciones. Censura, acoso.	Amenazas graves de daño físico o muerte, abandono o institucionalización. Vejaciones, intimidación, humillaciones, chantaje, insultos a personas sin demencia o con demencia leve o moderada.

TRUJILLO FORMACIÓN

Indicadores.		
Menos grave	**Grave**	**Muy grave**
Tristeza. Pérdida de autoestima. Infantilización delante de profesionales u otras personas. No proporcionar información y utilización de silencios ofensivos. Interés por agradar al cuidador.	Soledad y abandono. Depresión sin riesgo de autolesiones. Estrés, ansiedad. Aceleración del proceso de demencia. Alopecia por estrés Alteraciones del sueño. Pérdida de apetito. Llanto. Indecisión para hablar. Justificación de la actitud del cuidador como algo normal. Automarginación / aislamiento voluntario	Pánico, miedo en presencia del sujeto causante. Mutismo. Depresión e intentos de suicidio. Estado de bloqueo emocional. Alto grado de confusión y estrés. Trastornos del sueño, pérdida de apetito y peso. Indefensión, bloqueo. Imposibilidad de reacción. Aislamiento social.

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS.

Privar a la persona mayor de los derechos que legalmente le corresponden (intimidad, toma de decisiones, opción religiosa, participación social, confidencialidad, derecho a ser cuidado, libertad de elección...).

Menos grave	**Grave**	**Muy grave**
Equiparable a maltrato psicológico menos grave.	Impedimentos para que la persona mayor desarrolle sus capacidades y tome sus propias decisiones.	Retención ilegal, abuso de poder, aislamiento forzoso.

Indicadores.		
Menos grave	**Grave**	**Muy grave**
Equiparable a maltrato psicológico menos grave. Tristeza. Pérdida de autoestima. Infantilización delante de profesionales u otras personas. No proporcionar información y utilización de silencios ofensivos. Interés por agradar al cuidador.	Escasas visitas que generalmente recibe en compañía del cuidador, al igual que escasas salidas fuera del domicilio. No proporcionar estímulos a la persona mayor dependiente. Aislar a una persona de sus redes sociales.	El responsable no abre la puerta, rechaza recursos, no acude a los servicios sanitarios ni recibe visitas en casa. Institucionalización sin consentimiento.

TRUJILLO FORMACIÓN

MALTRATO SEXUAL.

Cualquier contacto sexual sin consentimiento (atentados contra el pudor e intimidad de la persona, tocamientos, violaciones, sodomía, desnudo forzado, fotografía sexual explícita...). Uso de la fuerza o amenazas para fines sexuales. Utilización de drogas o alcohol. Sumisión física o química.

Muy grave:

AGRESIÓN- VIOLACIÓN

Relaciones sexuales sin consentimiento (con penetración o sin ella). Tocamientos sin consentimiento con clara intencionalidad sexual.

Indicadores.

Muy grave.

Lesiones en el área genital, de diversa intensidad (desgarros, hemorragias).

Enfermedades de trasmisión sexual u otra infección.

Ropa interior rasgada, ensangrentada o con presencia de semen.

Temor y vergüenza por parte de la víctima ante el desnudo (oculta sus genitales, ansiedad, llanto). Siempre que la víctima tenga deterioro cognitivo se considerará especialmente grave, aunque las lesiones lo sean menos.

MALTRATO FINANCIERO.

Uso inapropiado de los recursos de la persona mayor: privarle de su patrimonio, negarle dinero en metálico para sus gastos personales o coaccionarle para que disponga de su patrimonio a favor del maltratador o impedir su utilización en favor de unos cuidados necesarios.

Menos grave	**Grave**	**Muy grave**
El responsable utiliza dinero para gastos personales. Abuso económico aparentemente consentido, mediado por cierto chantaje emocional.	El responsable gestiona de forma irresponsable el dinero de tal forma que carecen de algunos alimentos básicos, no pagan algún suministro y necesitan pedir dinero para llegar a fin de mes.	Robo por parte del cuidador (familiar o persona de confianza) de bienes económicos con violencia o sin violencia/intimidación de bienes económicos de la persona mayor, que le impiden cubrir sus necesidades básicas de atención, incluidos los recursos que necesita, dejándola en situación de extrema necesidad.

Indicadores.

Menos grave	**Grave**	**Muy grave**
Queja de la persona mayor sobre la solicitud de pequeñas cantidades de dinero por parte del cuidador.	Impago de los servicios de atención, a pesar de contar con ingresos.	Impago de los servicios de atención. Cuenta del banco en números rojos o con retirada de cantidades sin justificar.

TRUJILLO FORMACIÓN

	Cubre las necesidades básicas, pero existe un deterioro progresivo de su nivel de vida.	Corte de suministros. Carencia de alimentos. Orden de desahucio. Falsificación de la firma. Rechazo de recursos necesarios.

ABANDONO.

Claudicación total por parte de la persona encargada de prestar cuidados necesarios para asegurar su atención física. Abandono en lugares públicos sin posibilidad de comunicarse o demandar ayuda. Institucionalización forzosa en residencia o centro por medios coercitivos.

Muy grave:

Abandono de una persona mayor con necesidad de cuidados e incapacidad para procurárselos por sí misma, en un servicio, generalmente social o sanitario.

Indicadores.

Muy grave.

Localización de una persona mayor en cualquier lugar que no corresponda a su entorno e información de la situación por parte de servicios sanitarios y/o sociales, vecinos.

VIOLENCIA DE GÉNERO.

La ONU define la Violencia contra las mujeres como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".

Es la violencia ejercida sobre la mujer por el hecho de ser mujer o que se comete mayoritariamente contra las mujeres.

La violencia de género supone una violación de Derechos Humanos: integridad física y psicológica, salud, seguridad personal, no discriminación, libertad de movimiento, libertad de elección del lugar de residencia, no tortura o trato degradante.

Gradación del riesgo.

Grave	**Muy grave**
Antecedentes de violencia de género en la vida de pareja, ya sea constatados por denuncias previas, órdenes de alejamiento u otras medidas judiciales, aunque estén ya prescritas, o por el relato de la propia mujer o allegados. Detección de indicadores de violencia de género, aunque esta situación no sea identificada como tal por la mujer.	Situación de riesgo inminente o a corto plazo, para la integridad física o psicológica de la mujer. • Situación de dependencia física, deterioro cognitivo o ambos en la mujer. • El maltratador es el cuidador principal • Deterioro cognitivo y/ o enfermedad terminal en el maltratador

TRUJILLO FORMACIÓN

	• Perdida de comunicación y contacto de los profesionales con la mujer.

Indicadores de violencia de género.

Lesiones o secuelas de estas en diferentes estados de evolución.

Hiper frecuentación de servicios de urgencia u hospitalizaciones.

Quejas somáticas recurrentes: cefaleas, dolor crónico, molestias gástricas…etc.

Accidentes recurrentes.

Trastornos de sueño, de alimentación, agotamiento físico.

Consumo de psicofármacos.

Ansiedad, síntomas de estrés, Irritabilidad, baja autoestima, fobias.

Inhibición, retraimiento, evita contacto ocular.

Aislamiento social y familiar, falta de control sobre la economía familiar.

No cobertura de necesidades fisiológicas o de contacto social por falta de apoyo o impedimento del cuidador (muy frecuente en mujeres mayores y con dependencia).

Rechazo a los recursos de apoyo domiciliario, especialmente cuando este rechazo parte del maltratador.

Pérdida de comunicación y contacto de los profesionales con la mujer.

2.3.- HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN.

Durante el año 2020 se realizó la revisión de la escala de la anterior guía para poder incorporarla como instrumento validado en la detección del maltrato. La revisión dio lugar a dos instrumentos: la **ficha de factores de riesgo** y la **escala municipal de detección y graduación.**

Mientras la ficha de factores de riesgo puede ser utilizada en servicios menos especializados y para una valoración más inmediata, la escala de detección y graduación se plantea para entornos en los que se va a trabajar específicamente con la situación de maltrato.

• **Ficha de factores de riesgo**, de utilidad para una primera aproximación ante la sospecha de posible maltrato.

La Ficha de factores de riesgo visibiliza los factores que apoyan la sospecha de malos tratos a las personas mayores en su entorno domiciliario. La sospecha se basa en observaciones tanto de la (presunta) víctima como de la (presunta) persona responsable de los malos tratos.

• **Escala municipal de detección y graduación**, que se debe utilizar en el momento de la detección y orienta hacia el tipo de intervención.

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

Una vez que se han valorado los factores de riesgo, se pasa a la detección de la existencia de malos tratos a la persona mayor en su ámbito domiciliario. La escala recoge diferentes tipos de indicadores:

- Psicológicos/conductuales
- De salud o abandono físico y negligencia
- Ambientales
- Económicos
- Físicos de lesiones

La confirmación de la existencia de maltrato no se hace solo a través de la aplicación de un instrumento de sospecha, sino que además hay que realizar una evaluación que incluya tanto a la persona mayor como a la persona responsable del maltrato y al contexto de la situación.

La escala presenta tres columnas que responden al momento en que esta se aplica. La existencia de las columnas ayuda a percibir objetivamente en qué medida la detección inicial ha sufrido variaciones a lo largo del proceso.

• La **primera columna** se responde la primera vez que se aplica la Escala, en la **DETECCIÓN**.

• La **segunda columna** lo responde el **Equipo de Maltrato/Mesa de Vulnerabilidad** (EM/MV en adelante) a modo de **VERIFICACIÓN,** para determinar si el caso en cuestión es susceptible de incorporar al Programa de Maltrato.

• La **tercera columna** se responde al final, como forma de **CIERRE**, tras la valoración global y el plan de intervención **(EM/MV)**.

Es **observacional** y **mediante entrevista**: los datos se recogen en presencia de la presunta víctima, en su domicilio habitual y convenientemente con la presencia de la persona presuntamente responsable del maltrato.

Es **descriptiva**: se intenta disminuir la subjetividad de la persona que lleva a cabo la observación. En la ella se especifican los rasgos y variables que, de presentarse, deben ser cumplimentados.

2.4.- INTERVENCIÓN EN MALOS TRATOS.

En la intervención en malos tratos hay que diferenciar desde dónde se va a realizar el abordaje de la intervención, que planteará desde la **gradación del maltrato.**

Tipo de riesgo.	Valoración.	Intervención.
Menos graves	. Atención social primaria	. Atención social primaria. . Apoyos para la intervención social.
Graves	. Equipos de Atención a la Vulnerabilidad. . Mesa de Vulnerabilidad.	. Recursos acordados por el Equipo de Atención a la Vulnerabilidad. . Programa de Maltrato.
Muy graves	. Equipo de Atención a la Vulnerabilidad. . Mesa de Vulnerabilidad.	. Recursos acordados por el Equipo de Atención a la Vulnerabilidad. . Programa de Maltrato. . Servicios de Emergencia.

TRUJILLO FORMACIÓN

MALOS TRATOS MENOS GRAVES.

Las actuaciones en el caso de que los malos tratos sean menos graves corresponden a **Atención Social Primaria** desde donde se articulan los servicios necesarios para evitar un empeoramiento de la situación.

La gestión del caso recae en el **trabajador social de zona**, que, al tener una visión global del caso, será el responsable de la gestión de recursos y de la coordinación con el resto de los servicios. En el caso de que exista un trabajador social responsable del Programa de Mayores, la coordinación entre ambos profesionales será constante.

La valoración inicial ha de tener en cuenta las necesidades de apoyo y cuidados que requiere la persona mayor y la capacidad de autogobierno de las personas estudiadas. Esta valoración implica el desarrollo de un Diseño de Intervención Social (en adelante DIS) en el que se han de reflejar los objetivos a conseguir, los recursos que se van a tramitar, el pronóstico y la frecuencia de seguimiento del caso.

Se ha de tener en cuenta que la inicial valoración del caso como caso menos grave no implica que no pueda producirse un empeoramiento, por lo que hay que estar alerta ante posibles cambios y en caso necesario, aplicar la escala de nuevo cuando se valore. Es imprescindible realizar un seguimiento del caso de cara a valorar estos cambios que puedan producir agravamiento.

Los recursos propios del sistema de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid servirán de apoyo y de "vigilancia" para estas situaciones. Así, podrán gestionarse los diferentes recursos que se valoren necesarios y apropiados para cada caso teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de la persona mayor: Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria, Comida a Domicilio, etc.

Son muchos los recursos que se pueden poner al servicio de estos casos de maltrato menos grave, orientados fundamentalmente al **control de riesgos**.

Una parte fundamental es el apoyo a las personas cuidadoras, tanto en el cuidado directo como en la posible sobrecarga. Así, pueden ser de gran utilidad los servicios prestados en domicilio o en el entorno próximo. La cartera de servicios está formada por el Servicio de Ayuda a Domicilio (en adelante SAD), Teleasistencia Domiciliaria (en adelante TAD), Centro de Día (en adelante CD), "Respiro Familiar", "Cuidar a Quienes Cuidan", etc.), pudiendo contar también con algunos aspectos concretos de esos mismos servicios, como puede ser el seguimiento, o de personas en riesgo por parte de TAD, el asesoramiento legal, o la figura del psicólogo/a u otros profesionales disponibles en SAD.

MALOS TRATOS GRAVES.

Tras la aplicación de la escala, los casos valorados como graves y muy graves, serán vistos en los Equipos Distritales de Atención a la Vulnerabilidad. Estos equipos, que se describen a continuación, se configuran como un espacio de reflexión conjunta que permite a los profesionales implicados en el caso un abordaje común y desde una perspectiva integral que consiga ser lo más completa y adecuada a las características de la situación.

Equipos Distritales de Atención a la Vulnerabilidad.

El trabajo comunitario y específico, de acuerdo con sus propias particularidades, en los distritos de Madrid, es clave para la intervención y detección de vulnerabilidades en las personas mayores.

Una de las medidas adoptadas en los Acuerdos de la Villa (Medida: MS.GT3.009/109) fue la creación de los Equipos de atención a la vulnerabilidad.

TRUJILLO FORMACIÓN

Se inició la puesta en marcha del proyecto piloto de los Equipos Distritales de Atención a la Vulnerabilidad (EDAV) en septiembre de 2021 en tres Distritos: Villaverde, Arganzuela y Salamanca, que en la actualidad funcionan como se describe a continuación:

Estructura y composición de la mesa.

Profesionales permanentes

• Persona responsable de la coordinación de la mesa. Es una Jefatura de Sección de programas o la persona responsable del programa de mayores dependiendo la plantilla de cada distrito.

• Secretaría: Bajo las indicaciones del coordinador o coordinadora, es la persona de apoyo administrativo, encargada de preparar las convocatorias, enviarlas con tiempo suficiente, recoger las actas de las reuniones, establecer los contactos necesarios, cursar las invitaciones. Se trata de una persona de apoyo a toda la mesa.

• Una persona representante de la Mesa de Vulnerabilidad.

Profesionales invitados

• Los municipales: Trabajador social de zona responsable del caso, representantes de policía, SAMUR Social, SAMUR PC, Madrid salud (adicciones, saneamiento ambiental, salud pública), violencia de género, unidad de atención al anciano frágil (dependiente de SAMUR social).

• Entidades, ONG, que trabajan en el distrito haciendo trabajo comunitario o voluntariado directo.

• Entidades prestadoras de servicios / responsables municipales de su gestión.

• Atención primaria de salud.

• Salud mental.

• Fiscalía/juzgados.

• Servicios sociales de la comunidad de Madrid (gestión de residencias).

Las reuniones son mensuales con 5 expedientes con la posibilidad de incluir uno más de urgencia.

Su función es analizar los casos de personas mayores supuestamente vulnerables, en riesgo, detectadas por cualquiera de los agentes que operan en el distrito, buscar la mejor opción posible para revertir la situación y coordinar con cuántos recursos puedan ponerse a disposición de este propósito, en un intento de normalización, siempre respetando la autonomía de la persona mayor.

Tiene especial interés la puesta en común de casos especialmente complejos, para lo cual se hace necesario tener unos criterios uniformes y previos, tanto en relación del tipo de vulnerabilidad a abordar como de su severidad.

Los casos graves y muy graves se abordarán en las mesas distritales, para encontrar la mejor intervención posible.

• En las mesas distritales, si se clasifica un caso como muy grave, se trabajará conjuntamente con los servicios de emergencia y policía.

• Los casos graves, con sospecha de maltrato, se analizarán por los equipos de atención a la vulnerabilidad y se derivarán a la mesa de vulnerabilidad municipal, puerta de entrada al programa específico de malos tratos.

• Los casos graves por necesidad social no cubierta, o sociosanitaria, se verán en la mesa distrital para diseñar el plan de intervención que se llevará a cabo desde el centro de servicios sociales.

Los casos tratados serán revisados en los equipos con la periodicidad que se estime en los acuerdos de la mesa, en los que también se recogerán las acciones a realizar por cada uno de los miembros implicado en el caso.

Los equipos también deben actuar como lugar de recopilación de experiencias distritales en relación con la vulnerabilidad, incluso en aspectos preventivos o de sensibilización.

TRUJILLO FORMACIÓN

Si en algún momento se quiere contar con la participación ciudadana, serán los foros locales y las mesas de personas mayores a ellos vinculadas, los que deberán ser tenidos en cuenta.

Mesa de Vulnerabilidad de la Dirección General de Mayores.

Se concibe como el lugar para valorar casos que se detectan por diferentes recursos, profesionales o servicios de atención a la ciudadanía. Está formada por un conjunto de profesionales de diferentes disciplinas (sanitarias y sociales) que analizan los casos. En el siguiente flujograma se refleja el funcionamiento de esta mesa.

Con las notificaciones recibidas en la Mesa de Vulnerabilidad se realiza un análisis y devolución de la valoración realizada a los servicios sociales distritales. De especial interés es la devolución de la valoración en las intervenciones realizadas por los servicios sanitarios, ya que éstas no llegan directamente al distrito, sí las de la policía.

Se hace un seguimiento exhaustivo del caso a través de la aplicación CIVIS.

Además de clasificar, la mesa sirve para registrar los casos, funcionando como un auténtico observatorio.

Esta mesa convoca también sesiones de casos complejos en intervención en los programas de aislamiento social y maltrato, para tomar decisiones conjuntas y colegiadas por el equipo multidisciplinar.

En estas sesiones, además de formar parte los integrantes habituales de la Mesa, intervienen otros agentes implicados en los casos.

3.- FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PARTICIPATIVO. PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS.

En las Memorias municipales en relación a las personas mayores se ha venido diferenciando entre dos grandes ámbitos de actuación:

- El fomento del envejecimiento activo y participativo.
- Personas mayores que necesitan cuidados.

El **fomento del envejecimiento activo** es competencia directa de actual **Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad no Deseada**, que tiene como misión **contribuir al bienestar de las personas mayores, a su autonomía y a su integración social, mejorando su calidad de vida**. Esta población abarca desde las personas más autónomas hasta las más vulnerables o con necesidad de cuidados que deberán recibir especial atención. Su visión es ser una organización de referencia para las personas mayores, los profesionales y la ciudadanía en general.

Con este fin, se han establecido dos **objetivos básicos**:

- Impulsar y promover que todas las áreas municipales **consideren al colectivo de personas mayores como parte activa y fundamental de la ciudadanía**, evitando la segregación y teniendo en cuenta sus opiniones y necesidades siguiendo las directrices de la red mundial de ciudades amigables con las personas mayores.
- **Mantener y ampliar programas y servicios, así como una red de centros de mayores, junto a los existentes de otras áreas como centros culturales, deportivos o de promoción de la salud**. Estas iniciativas favorecen la promoción del envejecimiento activo a través de prácticas como el ejercicio o el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

TRUJILLO FORMACIÓN

3.1.- PARTICIPACIÓN Y MUCHO MÁS.

Los servicios y programas que fomentan la participación se han diseñado tradicionalmente siguiendo criterios técnicos siendo la participación de los usuarios, reales o potenciales, casi inexistente. Pasar de diseñar "para" a diseñar "con" no es una tarea sencilla. A continuación, presentamos una selección de planes y programas relevantes. En este apartado analizamos las actuaciones relacionadas con esta premisa **"Participación y mucho más".**

PLAN DE ACCIÓN "MADRID, CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES".

Se basa en la premisa de que una ciudad amigable es aquella que facilita que la ciudadanía envejezca de forma activa proyectando sus estructuras y servicios para que todas las personas, independientemente de sus edades, habilidades y capacidades, disfruten de buena salud y vivan con seguridad participando activamente en todos los ámbitos de la vida social.

El actual **Plan Madrid, Ciudad Amigable con las personas mayores 2.021-2.023** toma como punto referencia las ocho áreas del entorno urbano y social que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica como claves para la salud y la calidad de vida de las personas (espacios al aire libre y edificios; transporte; vivienda; respeto e inclusión social; participación social; comunicación e información; participación cívica y empleo) y se estructuran en tres grandes ámbitos estratégicos:

- AE I - Entorno cívico y social: una ciudad para todas las generaciones.
- AE II - Prevención y atención integral: una ciudad que responde a las necesidades de la población mayor.
- AE III - Entorno urbano amigable: una ciudad que se adapta a todas las personas.

Alrededor de estos tres ejes, se articulan las acciones de todas las áreas municipales. Concretamente están proyectadas 109 acciones y 239 actuaciones.

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

El Ayuntamiento de Madrid, como miembro de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, ha incluido el **Índice de Envejecimiento Activo (IEA)** en la evaluación de su Plan de Acción 2021-2023, como ya hiciera con el plan anterior, con el fin de disponer de un elemento común al resto de la Unión Europea, una herramienta idónea tanto para la comparación con otras áreas o ciudades como por su valor en el seguimiento longitudinal a largo plazo.

Para su construcción se utilizan una serie de indicadores agrupados en cuatro dimensiones: empleo, participación social, vida independiente, saludable y segura, y capacidad y entornos apropiados para un envejecimiento activo, en población de 55 años o más.

CONSEJO SECTORIAL DE PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MADRID.

Su finalidad es canalizar la **participación de las personas mayores, a través de las asociaciones más representativas en la ciudad de Madrid.** Se estructura en Pleno, Comisión Permanente y grupos de trabajo.

El 24 de junio de 2020 se lleva a cabo la constitución del plenario del Consejo Sectorial de Personas Mayores de la ciudad de Madrid. Los grupos de trabajo son los siguientes: revisión del Reglamento del Consejo Sectorial, Servicios de Proximidad y Alternativas Habitacionales, Seguridad Vial, Ciudades Amigables, Soledad no Deseada y Centros Municipales de Mayores.

TRUJILLO FORMACIÓN

OPINIÓN Y CALIDAD.
La Dirección General de Mayores cuenta con un servicio de control de calidad que incluye, además de la valoración de estándares o las encuestas, una parte importante de evaluación cualitativa, grupos de mejora y comparativas de servicios. Dentro del programa de calidad se lleva a cabo la **evaluación de las cuatro cartas** de servicios existentes en relación con las personas mayores: Servicio de Ayuda a Domicilio (en adelante SAD), Teleasistencia Domiciliaria (en adelante TAD), Centro de Día (en adelante CD) y Centro Municipal de Mayores (en adelante CMM). La Dirección General de Mayores, lleva a el seguimiento y evaluación de estas cuatro Cartas, asegurando la recopilación sistemática de los datos referidos a los indicadores en ellas recogidos (incluyendo los datos de encuestas de satisfacción de los servicios objeto de la Carta) y su análisis periódico.

3.2.- CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES CON SERVICIOS INTEGRADOS.

Los **Centros Municipales de Mayores** son **equipamientos de servicios sociales**, creados y sostenidos por el Ayuntamiento de Madrid, **dependientes de las Juntas Municipales de Distrito**, dirigidos a estimular y promover todo tipo de actividades socio-culturales, ocupacionales, artísticas y recreativas, fomentando la convivencia y la participación de las personas mayores. Los socios se acreditan con la **tarjeta madridmayor.es.**

CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

Fecha de aprobación.	13 de marzo de 2.013.
Fecha de certificación.	23 de diciembre de 2.020.
Fecha de última evaluación	11 de marzo de 2.024.

El Ayuntamiento de Madrid ha promovido e impulsado la red de **Centros Municipales de Mayores** y cuenta en la actualidad con **91 Centros** que dan **cobertura a las necesidades y aspiraciones de ocio y tiempo libre de las personas mayores residentes en la ciudad de Madrid**.

Estos Centros son espacios que **promueven el envejecimiento activo y saludable, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y la prevención de la dependencia, potenciando la autonomía personal**. Además, favorecen las relaciones sociales y crean vínculos interpersonales, incluso entre generaciones, por lo que son un gran recurso contra la soledad no deseada.

Como pilar básico del envejeciendo activo, dan impulso a la participación ciudadana, algo que refleja su Reglamento, sin olvidar la perspectiva de género y los derechos humanos, favoreciendo una imagen del envejecimiento ajustada a la realidad. Esta participación se hace efectiva en las reuniones de coordinación de las Juntas Directivas con personal técnico municipal y en las Asambleas Generales de personas socias.

Los Centros Municipales de Mayores están alineados con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: **1. Fin de la pobreza, 3. Sanidad y bienestar, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 11. Ciudades y comunidades sostenibles y 17. Alianzas para alcanzar los objetivos** como base para la consecución del resto de objetivos.

TRUJILLO FORMACIÓN

SERVICIOS PRESTADOS.

Programas socioculturales, ocupacionales o formativos.	Con el objetivo de favorecer el envejecimiento activo, la calidad de vida, la relación y la convivencia, a través de distintas y variadas **actividades o talleres** gratuitos. Se planifican con la participación de las Juntas Directivas y se dinamizan por el servicio de animación sociocultural, del que disponen todos los Centros. ▪ Actividades de programación continua: manuales, culturales, artísticas, de mantenimiento físico, recreativas o de educación digital básica. ▪ Actividades puntuales o esporádicas: conferencias, carnavales, excursiones, visitas culturales o viajes, etc.
Servicios de comedor / cafetería.	El objetivo es favorecer las relaciones personales y una alimentación equilibrada, ofreciendo menús variados a precios asequibles.
Espacios de nuevas tecnologías.	La disponibilidad de aulas informáticas tiene como objetivo favorecer la formación informática. Son gratuitos.
Servicios sala de lectura.	El objetivo es favorecer el acceso a la información y servir de apoyo a la lectura. Es un espacio abierto y de carácter gratuito. ▪ Consulta de material bibliográfico. ▪ Prensa diaria, en formato digital o en formato papel.
Otros servicios.	Su objetivo es favorecer el envejecimiento activo y el bienestar, con precios asequibles: ▪ Podología. ▪ Peluquería.
Información.	Informar sobre la situación de los Centros y otras cuestiones relacionadas. Se encuentra en el siguiente vínculo Centros Municipales de Mayores. También en los Centros de Servicios Sociales y en los propios Centros.
Sugerencias, felicitaciones y reclamaciones.	▪ Gestionar las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones remitidas por la ciudadanía. ▪ Informar sobre su estado de tramitación.

Horario.	Todos los días del año (excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero), de 9 a 21 horas.
Requisitos.	Podrán ser personas socias de los Centros Municipales de Mayores quienes reúnan los siguientes requisitos: ▪ Estar empadronada la persona interesada en el municipio de Madrid. ▪ Tener 65 años cumplidos. ▪ Tener 60 años cumplidos y la condición de pensionista. ▪ Ser cónyuge o pareja de hecho de los grupos anteriores. ▪ Ser titular de la tarjeta madridmayor.es. Se puede obtener en cualquiera de las 26 Oficinas de Atención a la Ciudadanía Línea Madrid.

TRUJILLO FORMACIÓN

COMPROMISOS DE CALIDAD.

Compromiso 1. Ofrecemos **actividades manuales, culturales, artísticas y de mantenimiento físico** en todos los distritos y las garantizamos, al menos, en el 95% de los Centros. El objetivo es que el 90% de las personas socias valore estas actividades con una puntuación igual o superior 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 2. Ofrecemos **servicio de sala de lectura** en el 90% de los Centros. El objetivo es que el 85% de las personas socias valore estos servicios con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 3. Ofrecemos **servicio de podología** en el 75% de los Centros. El objetivo es que el 80% de las personas socias valore estos servicios con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 4. Ofrecemos **servicio de peluquería** en el 70% de los Centros. El objetivo es que el 80% de las personas socias valore estos servicios con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 5. Disponemos de **aulas informáticas** en el 95% de los Centros. El objetivo es que el 75% de las personas socias valore estos servicios con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 6. Realizamos **actividades con personas de diferentes edades,** al menos, en el 90% de los Centros. El objetivo es que el 87% de las personas socias valore estas actividades con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 7. Adaptamos las actividades a las **preferencias de las personas socias** y favorecemos su **participación** en la programación. Todos los Centros Municipales de Mayores celebran, al menos, una vez al año una Asamblea General y el 90% celebrarán reuniones de evaluación y planificación entre el equipo técnico y la Junta Directiva, en representación de las personas socias.
Compromiso 8 **Informamos** a las personas socias sobre los programas y servicios que se desarrollan en el Centro Municipal de Mayores en el momento de su incorporación. El objetivo es que el 85% valore la información recibida con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 9 Contamos con **espacios adecuados y confortables** en los Centros Municipales de Mayores. El objetivo es que el 82% de las personas socias los valore con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 10 Prestamos el servicio en un **horario** amplio. El objetivo es que el 90% de las personas socias lo valore con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.

TRUJILLO FORMACIÓN

Compromiso 11
Ofrecemos un **servicio de comedor** con menús equilibrados y a precios económicos. El objetivo es que el 80% de las personas socias lo valore con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 12
Garantizamos que las **personas que trabajan** en los Centros (*) van **identificadas** con una tarjeta visible. (*) Coordinadora/or de mayores, auxiliar de información, peluquera/o, podóloga/o, animadora/or sociocultural, monitoras/es contratadas/os de talleres y camareras/os.
Compromiso 13
Atendemos de forma **adecuada, amable y respetuosa** a las personas socias. El objetivo es que el 90% valore el trato recibido con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 14
Prestamos un **servicio de calidad**. El objetivo es que el 92% de las personas socias lo valore con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10, y que el 95% se lo **recomiende** a otras personas.
Compromiso 15
Contestamos el **60% de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones** como máximo en **30 días** naturales y en ningún caso en un plazo superior a 2 meses.

Los Centros Municipales de Mayores son equipamientos que gestionan una serie de **servicios integrados.** En la actual Memoria se recogen los siguientes:

TARJETA MADRIDMAYOR.ES
Esta tarjeta tiene como finalidad: • Acreditar a la persona titular como socia de su Centro Municipal de Mayores de referencia. • Facilitar el acceso a una serie de servicios y bienes, en condiciones ventajosas respecto al resto de la población. Es lo que se conoce como el Programa de Beneficios Sociales.
PROGRAMA DE BENEFICIOS SOCIALES.
A través de esta iniciativa las personas mayores que dispongan de la tarjeta madridmayor.es podrán disfrutar de las ventajas y beneficios que los comercios, establecimientos y entidades colaboradoras pongan a su disposición.
ESPACIOS-AULAS INFORMÁTICAS.
En la actualidad hay un total de 92 aulas informáticas ubicadas en 88 Centros Municipales de Mayores.

TRUJILLO FORMACIÓN

PODOLOGÍA EN CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

En 2022, el servicio de podología ha sido prestado a través de dos empresas. Dichas empresas se han encargado de la gestión de los gabinetes de podología de los CMM, llevando a cabo los siguientes servicios:

• Atención podológica a las personas usuarias.

• Gestión de citas.

• Mantenimiento correctivo y reparación del equipamiento y material existente en los gabinetes.

• Sustitución, en su caso, del material de podología que lo requiera.

COLABORACIÓN CON EL ÁREA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO. PROYECTO PILOTO "BANCA DIGITAL".

El proyecto tiene como objetivo principal mejorar la información de las personas mayores sobre el uso de la banca on-line, de manera que las personas asistentes adquieran nociones básicas sobre las aplicaciones y la navegación para realizar las gestiones bancarias más comunes por vía digital.

El programa se desarrolló durante los meses de abril, mayo y junio en una sesión práctica de una hora y media de duración en varios Centros de Mayores de los 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN RELACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS.

a) Taller para el manejo de móviles "SECOT"

La Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) ha colaborado un año más en la impartición de talleres sobre el uso de los smartphones y aplicaciones dirigidas a personas mayores, con una nueva edición del programa "APPrende a usar tu móvil".

b) Talleres para la formación en TIC para mayores "EMANCIPATICS"

El objetivo principal de los talleres es que los/as alumnos/as adquieran la compresión y manejo del dispositivo, así como, de gestión de la información en redes sociales y mensajería. Emancipatics solamente llevó a cabo tres sesiones de trabajo, en el Centro Municipal de Mayores El Almendro, del distrito de Vicálvaro, el resto tuvo que ser suspendido por falta de financiación en la entidad.

TALLERES PREVENCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS.

Desde el Cuerpo de Bomberos se realiza el proyecto de Taller de Prevención del Cuerpo de Bomberos realizado por su Grupo Pedagógico. Se imparte en sesiones teóricas y prácticas, el objetivo es dar a conocer los procedimientos de actuación y los medios de los que dispone el Cuerpo de bomberos en las intervenciones que realizan, así como educar a las personas mayores en la prevención de riesgos en el hogar y en otros ámbitos de la vida cotidiana, y en la autoprotección cuando se den situaciones de emergencia (nociones básicas sobre evacuación en lugares de ocio, Centros comerciales etc).

CONCURSO DE BELENES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

Con el objeto de contribuir a mantener las tradiciones orientadas a conmemorar las fiestas navideñas y fomentar la actividad artística de los mayores se convoca el XXXI Concurso de Belenes de CMM en el Ayuntamiento de Madrid.

CERTAMEN DE TEATRO "MAYORES A ESCENA" DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

Tras el periodo de suspensión del certamen de teatro, por motivos de la pandemia entre 2020-2021, se retomó la actividad durante el mes de mayo.

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

3.3.- EJERCICIO COMO EXPONENTE DE ACTIVIDAD SOCIAL Y SALUDABLE.

No hay duda de que el ejercicio es uno de los pilares básicos para envejecer bien. A sus bondades sobre el aspecto físico, se unen beneficios en el plano psicológico y social (sobre todo si se trata de una actividad grupal).

Conscientes de esto, se promueve el ejercicio en distintos dispositivos municipales, principalmente equipamientos deportivos y centros para personas mayores.

Como complemento a esa actividad, disponemos del **programa de ejercicio al aire libre y la fisioterapia preventiva** (esta última dirigida a colectivos con ciertas limitaciones funcionales).

PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO AL AIRE LIBRE "MOVERSE ES CUIDARSE".
El programa va dirigido a una población mayor de 60 años, prioritariamente con escasos hábitos en la práctica de ejercicio o con vida sedentaria, pero también para aquellos que ya están realizando otra actividad física. Tiene una periodicidad semanal de una hora y siempre está dirigido por personal cualificado. Como objetivo final sería hacer del ejercicio un hábito de vida en la población mayor y, entre otros, promover la sociabilización y el fomento de las relaciones personales. En 2022 se han realizado 20 encuentros intergeneracionales con mayores y escolares, distribuidos en los distritos de la capital.
OBSERVATORIO DE PLAZAS DE ACTIVIDAD FÍSICA.
Se lleva un registro de plazas ofertadas tanto en centros deportivos como en centros de mayores, en ambos casos, específicas para personas mayores.
SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
Esta actividad tiene como finalidad mejorar la capacidad personal de las personas mayores evitando y/o retrasando el deterioro progresivo, mediante actividades de fisioterapia grupal de mantenimiento. La atención se realiza en los CMM, en grupos configurados entre 10 y 15 personas y el personal técnico que realiza esta actividad es fisioterapeuta.

3.4.- VIVIENDA Y CONVIVENCIA.

Existen alternativas habitacionales que merece la pena señalar.

APARTAMENTOS MUNICIPALES PARA MAYORES.
Los apartamentos para mayores son un equipamiento de servicios sociales de carácter residencial destinado a personas válidas, que carecen de vivienda y de los recursos necesarios tanto económicos como familiares y sociales para acceder a ella. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con dos equipamientos, con una capacidad total de 100 plazas. Va dirigido a personas mayores de 65 años, o 60 en caso de cónyuges u otras personas que convivan a cargo del solicitante. Los usuarios gozan de total independencia dentro del apartamento, aunque deben respetar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

TRUJILLO FORMACIÓN

Apartamentos Municipales para Mayores San Francisco.	Consta de 41 Apartamentos para Mayores con capacidad para 68 personas. Distrito Centro.
Apartamentos Municipales para Mayores de Retiro.	25 Apartamentos para Mayores con capacidad para 32 personas. Distrito Retiro.

Los requisitos para acceder son:

- Estar empadronado en el municipio de Madrid.
- Estar en buen estado físico y psíquico para realizar actividades de la vida diaria de forma independiente.
- Carecer de alojamiento estable o ser este inadecuado.
- Estar dispuesto a ingresar en una residencia, cuando la persona requiera apoyo.

PROGRAMA DE CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL "CONVIVE".

Es un programa de solidaridad intergeneracional cuyo objetivo principal es potenciar las relaciones entre personas mayores de 65 años o más, y jóvenes estudiantes universitarios en un clima de convivencia. Se pretende con ello que puedan compartir no solo la vivienda, sino mucho más: conocimientos, experiencias o emociones, en el seno de una relación de ayuda.

Su carácter marcadamente social fomenta la solidaridad entre las dos generaciones, así como la comunicación y el intercambio de experiencias; proporciona ayuda para atenuar el problema de soledad de las personas mayores; y facilita alternativas de alojamiento a jóvenes universitarios (algo de especial utilidad para los que acceden desde fuera de Madrid), promoviendo y facilitando relaciones de ayuda mutua entre generaciones.

Este programa se gestiona en virtud de los convenios de colaboración firmados con la entidad Solidarios para el Desarrollo y con siete Universidades madrileñas.

3.5.- PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD.

Son múltiples las acciones encaminadas a paliar los sentimientos de soledad o a proporcionar acompañamiento a quienes viven solos. Muchas de ellas están recogidas aquí, en el bloque de envejecimiento activo, ya que los CMM y otros programas grupales tienen un claro carácter preventivo.

La colaboración de entidades como "Solidarios para el Desarrollo", "Nadie Solo" y "Grandes Amigos", es vital para el apoyo a las personas mayores que se sienten solas mediante acompañamiento domiciliario. A ellos hay que añadir los proyectos realizados desde los distritos.

Programa de acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas.

Desde junio de 2021 se lleva a cabo el "Programa de acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas", que consiste en la prestación de un servicio de valoración y acompañamiento, por un equipo especializado, a personas mayores que sufren soledad no deseada, mediante atención individual domiciliaria y atención grupal de carácter preventivo a través de talleres de soledad.

TRUJILLO FORMACIÓN

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL.

Programa de acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas (intervención individual en el domicilio).

Población a la que se dirige.	Personas mayores de 65 años que sufren soledad no deseada o están en riesgo de padecerla, entre nuevos usuarios de servicios domiciliarios.
Objetivo.	Prestación de un servicio de valoración y acompañamiento, por un equipo especializado, a personas mayores que sufren soledad no deseada, mediante atención individual domiciliaria. Tiene como finalidad realizar un contacto y enganche, informar de los recursos adecuados a su situación y favorecer su aceptación e integración social.

Las personas usuarias proceden de las altas de los servicios domiciliarios facilitados por el Departamento de SAD que son remitidos a la entidad desde Departamento de Programación Evaluación y Desarrollo para valoración, derivadas desde los centros de servicios sociales o desde otros programas o servicios.

INTERVENCIÓN GRUPAL.

Programa de acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas (intervención grupal).

Población a la que se dirige.	Personas mayores de 65 años que sufren soledad no deseada o están en riesgo de padecerla, entre nuevos usuarios de servicios domiciliarios.
Objetivo.	Prestación de un servicio de valoración y acompañamiento, por un equipo especializado, a personas mayores que sufren soledad no deseada, mediante atención grupal de carácter preventivo destinadas a hacer prevención universal, selectiva e indicada.

La intervención grupal se lleva a cabo mediante talleres que se imparten en febrero-marzo, abril-mayo y octubre-noviembre, realizándose en dependencias municipales como CSS, CMM, Centros Culturales y Bibliotecas Municipales.

Los talleres desarrollados en esos periodos han sido sobre "Envejecimiento Activo", "Habilidades sociales", "Apoyo social" y "Abordaje de la soledad", cada uno de ellos compuesto de 8 sesiones, donde se desarrolla el contenido adaptado al grupo, con una metodología dinámica, participativa y de cooperación entre las personas participantes.

COLABORACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE CIUDAD EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA JUNTO AL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD.

En este convenio se establecen los siguientes objetivos:

• Intercambio de información sobre programas y servicios.

• Difusión sobre programas, servicios o actuaciones de ambas partes que puedan ser de interés, tanto a personas usuarias como a entidades relacionadas, así como a través de los medios de comunicación propios (redes sociales).

• Establecer criterios de coordinación que faciliten y refuercen el abordaje sociosanitario desde un enfoque integral.

TRUJILLO FORMACIÓN

• Impulsar acciones conjuntas que, con carácter estable, promuevan programas dirigidos especialmente a las personas y grupos de personas que pueden acumular problemas y/o circunstancias que les hacen especialmente vulnerables.

A través de esta colaboración se realiza un documento explicativo de las actuaciones que se realizan a nivel conjunto en prevención y abordaje de la soledad no deseada desde el Ayuntamiento de Madrid, separando y distribuyendo todas las actuaciones en tres grandes bloques:

▪ Prevención universal, dirigida a la población general, instituciones y organizaciones. Son espacios de encuentro para informar y sensibilizar para prevenir la soledad no deseada.

▪ Prevención selectiva (actuaciones de detección, sensibilización, divulgación e investigación), dirigida a personas o grupos con mayor riesgo de sentir soledad.

▪ Prevención Indicada (Intervención), dirigida a personas o grupos identificados con sentimientos de soledad que generan malestar.

3.6.- SENSIBILIZACIÓN.

El objetivo es integrar el trabajo de atención con el de sensibilización en materias de envejecimiento activo, fragilidad y vulnerabilidad de las personas mayores. El mensaje se dirige a la ciudadanía o a grupos de población específicos como son mayores, personas cuidadoras o agentes intermedios, poniendo en marcha los medios más oportunos de información.

Estas actividades promueven la sensibilización de la ciudadanía sobre temas que afectan directamente a nuestros mayores: actitudes, aptitudes, valores, estilos de vida generadores de salud, recursos que apoyan la permanencia de las personas mayores en su domicilio, y en especial las situaciones de necesidad social, abandono y negligencia. Una de las herramientas es el portal 'Mayores' alojado en www.madrid.es.

4.- PERSONAS MAYORES QUE NECESITAN CUIDADOS. PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS.

La Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad no Deeada de la ciudad de Madrid tiene como **misión promover programas y servicios con el fin de mantener a las personas mayores en su propio hogar el máximo tiempo posible integrándolas en su entorno, apoyar a las familias que las cuidan, y promover soluciones de ayuda y apoyo para cuando no puedan mantenerse en él.**

También se trata de **detectar problemas emergentes, y diseñamos estrategias para solventarlos, evaluarlos y realizar controles de calidad.** Su visión es ser una organización de referencia, para las personas mayores y sus familiares, por la cercanía y efectividad de sus servicios; ofreciendo modelos de intervención en las prestaciones que favorezcan la permanencia en el hogar, y en el impulso y desarrollo de nuevos modelos de atención.

Se han establecido dos **objetivos básicos**:

- **Mantener y ampliar la red de servicios de apoyo prestados en el hogar** (a través de mecanismos como el Servicio de Atención de Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria, Comida a Domicilio, etc.) y en recursos como los centros de día, así como los programas específicos de apoyo a quienes cuidan, por medio de programas de respiro familiar o los grupos psicoterapéuticos.

TRUJILLO FORMACIÓN

TRUJILLO FORMACIÓN

- Establecer **una red de protección para las personas mayores vulnerables, especialmente por soledad, aislamiento social o maltrato**, mediante actuaciones coordinadas y programas específicos.

Como casi toda clasificación de la población en colectivos, la división de las personas mayores en bloques diferenciados es arbitraria, ya que todas ellas pueden ser más o menos vulnerables o dependientes, envejecer activamente o precisar algún tipo de apoyo. No obstante, por razones de comprensión, al envejecimiento activo ha sido desarrollado en el bloque temático que precede al que nos ocupa en estas páginas.

4.1.- ENVEJECER EN CASA.

Favorecer la permanencia de las personas mayores en su domicilio, incluso en situaciones desfavorables por deterioro funcional o mental, requiere apoyos tanto en el domicilio como en la comunidad, disponiendo de diversos programas y servicios para la atención directa las personas mayores como a sus familiares.

Debemos destacar, asimismo, los grupos de mejora realizados con profesionales de los distintos departamentos de la Dirección General de Mayores y de otras Direcciones Generales municipales, en los que se han trabajado aspectos transversales, que tienen un significado especial en las personas mayores (la necesidad de visibilizar y sensibilizar la realidad de las personas mayores LGTBI, identificar y establecer mejoras sobre el programa de violencia de género en las personas mayores, y sobre la brecha digital).

4.2.- SERVICIOS DOMICILIARIOS PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

El **Departamento de Servicios de Ayuda a Domicilio**, tiene como cometido fundamental la **gestión, control y seguimiento** de los siguientes servicios:

- **Ayuda a Domicilio (en adelante, SAD).**
- **Teleasistencia Domiciliaria (en adelante, TAD).**
- **Comida a Domicilio.**
- **Lavandería Domiciliaria.**
- **Productos de Apoyo.**

A ello se le une el control y seguimiento presupuestario, el seguimiento trimestral de los indicadores y compromisos de las Cartas de Servicios de SAD y TAD, el análisis del grado de satisfacción de las personas usuarias y la gestión de las sugerencias y reclamaciones en relación a la prestación de los 5 servicios gestionados en el Departamento.

TRUJILLO FORMACIÓN

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD).

El objetivo fundamental del SAD es **promover la independencia y autonomía personal de las personas usuarias, favoreciendo el que puedan mantenerse en sus domicilios el mayor tiempo posible, mejorando así su calidad de vida.**

Desde este Servicio se proporciona una **intervención profesional individualizada, de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador**, según su perfil y sus necesidades, y en función del riesgo social o vulnerabilidad en que se encuentre, consistente en la **prestación de atenciones básicas de carácter personal, doméstica o ambas, a través de personal auxiliar domiciliario**. Además, de forma complementaria, se incluyen una serie de **prestaciones realizadas en el domicilio por profesionales específicos como psicólogos/as, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, podólogos/as y servicio de peluquería,** que contribuyen a proporcionar una intervención más integral a la persona, así como la realización de actividades y talleres socioculturales que facilitan el envejecimiento activo.

Las personas beneficiarias de este servicio son:

- Personas mayores de 65 años con dificultades en su autonomía y que tengan una necesidad de apoyo, que requieran supervisión, ayuda parcial o total para el desempeño de las actividades de la vida diaria.
- Personas menores de 65 con discapacidad reconocida.
- Personas declaradas dependientes por la Comunidad de Madrid.

Durante el año 2022, incluyendo personas mayores y personas con discapacidad, y partiendo del objetivo propuesto en los presupuestos de proporcionar atención a 83.000 personas mediante el SAD, se destaca el amplio cumplimiento de dicho objetivo, consiguiendo dar cobertura con este servicio a 85.024 personas con más de 11.638.740,50 millones de horas prestadas.

El **SAD para personas mayores tiene dos vertientes**: SAD preventivo (o SAD Atención Social Primaria) y el SAD que se ofrece a las personas que tienen reconocida la situación de Dependencia por la Comunidad de Madrid y que tienen incluido en su Programa Individual de Atención (PIA) este servicio (SAD Dependencia).

En el año 2022 se ha prestado servicio a 79.566 personas mayores, de las cuales 60.028 han sido mujeres y 19.538 hombres, superando el número de usuarios del año 2020. Asimismo, se ha experimentado un incremento en el número de horas prestadas del 23,68%, manteniéndose la tasa de cobertura en 11,9% respecto a la población mayor de 65 años de la ciudad de Madrid.

Con relación al perfil atendido, la edad media de las personas usuarias del servicio se mantiene igual que en el año 2021, en **85 años**. Por otro lado, las personas mayores de 80 años que viven solas y reciben el servicio, representan el 37,83% del total, un 2% más respecto al año anterior, lo que denota el progresivo sobreenvejecimiento de la población atendida.

En cuanto a la situación física, psíquica y social en la que se encuentran las personas beneficiarias del SAD ASP, y en base a los datos obtenidos del baremo social de necesidad (en adelante BSN), la mayoría se sitúan en un nivel de dependencia equivalente a un **Grado I de dependencia**.

El tipo de atención prestada indica la clase de apoyo que necesita la persona mayor (atención personal, doméstica o mixta) y la intensidad se justifica por su grado de necesidad. En este sentido, el SAD dedicado a la atención personal es el que refleja claramente una mayor intensidad horaria con una media de 24,82 horas al mes. No obstante, la prestación principal sigue siendo, como en años anteriores, la atención mixta (80,56%), seguida de la atención doméstica (15,17%) y la atención personal (4,27%).

TRUJILLO FORMACIÓN

Para la atención de las personas usuarias del servicio se cuenta con 351 coordinadores/as, 181 ayudantes de coordinación y 11.185 auxiliares de ayuda a domicilio. A ello se le unen otros perfiles profesionales que realizan las actividades complementarias: terapeutas ocupacionales, profesionales de psicología/as, fisioterapeutas, profesionales de podología/as, peluqueros/as, animadores/as socioculturales, etc. Estos servicios han sido muy demandados y se ha producido un aumento considerable en el número de atenciones con respecto a años anteriores.

CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Fecha de aprobación.	28 de abril de 2.011.
Fecha de certificación.	23 de diciembre de 2.020.
Fecha de última evaluación	11 de marzo de 2.024.

El **servicio** tiene como **objetivo** proporcionar atención personal y/o doméstica en el domicilio a las personas mayores, con la finalidad de que la persona pueda permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible, fomentando su autonomía personal y mejorando su calidad de vida, sin suplir la responsabilidad que corresponda a la familia. El servicio proporciona una atención profesional individualizada y se presta también a personas con discapacidad que lo precisan.

Esta Carta se alinea con los **Objetivos 1. Fin de la pobreza, 3. Sanidad y bienestar, 5. Igualdad de género, 11. Ciudades y comunidades sostenibles y 17. Alianzas para alcanzar los objetivos** como base para la consecución del resto de objetivos.

SERVICIOS PRESTADOS.

Atención personal.	▪ Apoyar en el aseo personal. ▪ Ayudar en el vestido, calzado y alimentación. ▪ Apoyar en traslados y movilizaciones dentro del hogar. ▪ Acompañar ocasionalmente fuera del hogar para la realización de diversas gestiones, como visitas médicas, tramitación de documentos y otras similares, siempre que no se disponga de apoyo familiar o de voluntariado. ▪ Gestionar en nombre de la persona usuaria recetas y documentos relacionados con la vida diaria, siempre que no exista apoyo familiar o de voluntariado, o así lo determine el personal técnico municipal. ▪ Ayudar en la toma de medicamentos prescritos (no están incluidas las actividades de carácter sanitario). ▪ Observar la evolución de la situación y poner en conocimiento de los servicios sociales los cambios e incidencias que se detecten.
Atención doméstica.	▪ Limpiar o ayudar a la limpieza cotidiana de la vivienda y a su mantenimiento en condiciones aceptables de higiene y salubridad. ▪ Adquirir alimentos y otros productos básicos por cuenta de la persona usuaria. ▪ Lavar, planchar y organizar la ropa dentro del hogar.

TRUJILLO FORMACIÓN

	▪ Preparar comidas en el hogar. ▪ Realizar pequeñas tareas de mantenimiento de utensilios domésticos y de uso personal, tales como cambio de bombillas, sustitución de pilas, cambio de bolsa de aspiradora, etc. ▪ Realizar, excepcionalmente, limpiezas de choque en los casos en que sea valorado técnicamente y se considere necesario.
Evaluación de necesidades, control y seguimiento del servicio.	▪ Acoger a la persona que hace la demanda, informarla sobre las características del servicio y realizar la valoración inicial. ▪ Comprobar el cumplimiento de requisitos necesarios. ▪ Diseñar la intervención social específica del servicio de ayuda a domicilio. ▪ Elaborar la propuesta del servicio de ayuda a domicilio consensuada con la persona atendida y sus familiares cuidadores. ▪ Realizar el seguimiento del servicio mediante entrevistas, visitas al domicilio y llamadas telefónicas, adecuando las prestaciones a los cambios detectados. ▪ Realizar el control del servicio garantizando el cumplimiento de las condiciones establecidas. ▪ Aportar pequeños productos de apoyo (salvo camas y grúas) como complemento a la atención personal, en los casos en que, valorado técnicamente, se considere necesario. ▪ Acceder a prestaciones individualizadas, realizadas por profesionales específicos (terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y psicólogo/a), a aquellos casos que determine el personal técnico de referencia de servicios sociales.
Información.	Informar sobre el servicio de Ayuda a Domicilio y otras cuestiones relacionadas. Se encuentra en el siguiente vínculo Servicios de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Madrid. También en los Centros de Servicios Sociales.
Sugerencias, felicitaciones y reclamaciones.	▪ Gestionar las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones remitidas por la ciudadanía. ▪ Informar sobre su estado de tramitación.

El **acceso a estos servicios** se gestiona en los Centros de Servicios Sociales de la Ciudad de Madrid, que valoran, diseñan la intervención, elaboran la orden de alta y realizan el seguimiento correspondiente. Se prestan en el domicilio, por auxiliares domiciliarios, que llevarán uniforme con el logotipo del Ayuntamiento de Madrid, en horario de 7 a 22 horas, de lunes a domingos. Desde el Servicio de Coordinación de las entidades, diplomados/as en Trabajo Social realizarán el seguimiento de la prestación, así como la coordinación del personal auxiliar domiciliario, según las pautas marcadas por el Ayuntamiento de Madrid.

Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio podrán contactar telefónicamente con las entidades prestadoras del mismo en el horario mencionado.

Los servicios que se concedan estarán limitados, en todo caso, por los recursos disponibles por el Ayuntamiento en cada momento.

En el supuesto de que exista un riesgo grave e inminente para la persona para la que se solicita el servicio, apreciado por el/la trabajador/a social, se podrá ordenar la inmediata prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

TRUJILLO FORMACIÓN

Personas destinatarias.	▪ Personas que hayan cumplido 65 años con dificultades en su autonomía personal y necesidad de apoyo. ▪ Personas con discapacidad menores de 65 años. ▪ Personas declaradas dependientes por la Comunidad de Madrid.
Requisitos.	▪ Ser español/a o con nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o con nacionalidad de otro país extracomunitario, pero con residencia legal en España. ▪ Estar empadronado/a en Madrid. Para personas mayores que residan temporadas que no excedan de 6 meses con los hijos, será suficiente con que los hijos o la familia de acogida estén empadronados. ▪ Todos aquellos requisitos que recoge la Ordenanza 10/2.022, de 28 de junio.
Coste del Servicio.	La persona usuaria participa en el coste del servicio en función de las horas recibidas y de su capacidad económica.

COMPROMISOS DE CALIDAD.

Compromiso 1. Atendemos de forma **adecuada, amable y respetuosa** a las personas usuarias. El objetivo es que el 90% valore el trato recibido con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 2. Realizamos **visitas de seguimiento** a las personas usuarias del servicio. El objetivo es que al menos el 97% de ellas reciba una al año. En ningún caso transcurrirán más de 18 meses entre las visitas.
Compromiso 3. Realizamos **visitas de seguimiento** a las personas usuarias con **alto riesgo social** (*). El objetivo es que al menos el 95% de ellas reciba una cada seis meses. En ningún caso transcurrirán más de 12 meses entre las visitas. (*) La valoración de riesgo social será realizada por profesionales de referencia de Servicios Sociales.
Compromiso 4. **Informamos por escrito** a todas las personas usuarias, al ser dadas de alta, sobre las características generales del servicio y los detalles particulares de la prestación, en cuanto a horarios, número de horas asignadas, tareas que se incluyen, personal auxiliar y coordinador de referencia y teléfonos de contacto.
Compromiso 5. Garantizamos que todos los **profesionales** del servicio tengan **la formación adecuada**. El objetivo es que el 85% de las personas usuarias valore la profesionalidad del personal auxiliar con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.

TRUJILLO FORMACIÓN

Compromiso 6.

Realizamos actuaciones para la **prevención y detección del maltrato** en los Servicios de Ayuda a Domicilio, disponiendo todas las entidades colaboradoras de un protocolo de detección del maltrato. El objetivo es que el 90% de los profesionales auxiliares domiciliarios, que lleven más de 6 meses en la empresa, estén formados en esta materia.

Compromiso 7.

Realizamos actuaciones para la **detección de situaciones de soledad** en los Servicios de Ayuda a Domicilio, disponiendo todas las entidades colaboradoras de un protocolo de detección de situaciones de soledad. El objetivo es que el 90% de los profesionales auxiliares domiciliarios, que lleven más de un año en la empresa, estén formados en esta materia. Además, el 90% de las personas usuarias, de nueva alta, son valoradas con las escalas correspondientes.

Compromiso 8.

Prestamos **un servicio de calidad** de forma que las personas usuarias estén **satisfechas** con el mismo. El objetivo es que el 85% valore el servicio con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10 y que al menos el 95% lo considere recomendable para otras personas.

Compromiso 9.

Contestamos el **60% de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones** como máximo en **30 días** naturales y en ningún caso en un plazo superior a 2 meses.

SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

Es un **servicio social de atención y apoyo personalizado, que permite a las personas usuarias, a través de una línea telefónica y con un sistema de comunicaciones e informático específico, disponer de un servicio de atención permanente, las 24 horas, todos los días del año**, atendido por profesionales con formación especializada y medios técnicos, para dar respuesta adecuada a las situaciones de necesidad social o de emergencia, incluida la movilización de otros recursos, si fuera necesario.

Con carácter general, este Servicio está destinado a **personas mayores de 65 años que reúnan los requisitos establecidos** por el Ayuntamiento de Madrid. Se prioriza a las que tienen **más de 80 años**, con especial hincapié a las que viven solas, por considerarse que tienen una mayor situación de riesgo. Asimismo, son beneficiarias las personas dependientes, independientemente de la edad, que tienen reconocido el TAD en su Programa Individualizado de Atención (PIA) y las personas con discapacidad menores de 65 años, que requieren el servicio por sus circunstancias de vulnerabilidad.

Este servicio claramente está consolidado desde 2018. Observando que en el 2022, el número de domicilios y personas usuarias atendidas ha decrecido un 3,37% y 3,44%, respectivamente, con respecto al año 2021, debido a una disminución en el número de altas (11,38%) respecto al año anterior.

Asimismo, hay que reseñar que, a lo largo de 2022, se valoraron 386 solicitudes de alta de menores de 65 años no dependientes, de las cuales fueron autorizadas el 98%, incrementándose un 38,77 % con respecto a 2021.

Por otro lado, durante 2022 el servicio se ha ido adaptando a los cambios tecnológicos que demanda la sociedad, representando las altas de domicilios con telefonía móvil un 20,10%, con respecto al total de altas realizadas, por lo que actualmente el 15,62% de los domicilios disponen de telefonía móvil.

TRUJILLO FORMACIÓN

Durante 2022, se atiende a 140.547 personas: 96.037 personas han sido atendidas en el marco de la iniciativa propia del Ayuntamiento de Madrid (cobertura universal y gratuita del Sistema de Teleasistencia para todas la personas mayores de 65 años), y 44.510 personas atendidas en el marco del sistema de atención a la dependencia, conveniado con la Comunidad de Madrid, incrementándose estos últimos en un 3,27% % respecto al año anterior.

El número de personas usuarias menores de 65 años ha aumentado un 38,77% respecto al año 2021, tal y como se viene constatando en años anteriores. De esta franja de edad el 64,95% son personas dependientes. No obstante, el envejecimiento de las personas atendidas es evidente, ya que el servicio es recibido mayoritariamente por personas mayores de 80 años (75,74%), destacando que el 28,63% de las personas tiene edades comprendidas entre 85 y 89 años.

Del total de personas usuarias del servicio, un 48,51% viven solas. Dentro de este perfil, por tramos de edad, destacan las personas mayores de 80 años, que representan el 75,32%, que han disminuido un 1,32% respecto al 2021.

El servicio de TAD ofrece una atención centrada en la persona e integral, que aborda no sólo la implementación de tecnología, sino también una **atención personalizada**, a través de los diferentes profesionales que integran el equipo (profesionales de psicología/as, DUEs y terapeutas ocupaciones), a los que se deriva aquellos casos en los que existe otro tipo de necesidades que puedan requerir asesoramiento y apoyo por su parte. Asimismo, a todas las personas usuarias se les realiza periódicamente una **valoración sociosanitaria** que determina el perfil de riesgo social y la intensidad del servicio.

Los datos a 31 de diciembre de 2022 son los siguientes: el 87,32% de las personas usuarias tienen riesgo social leve, el 10,53% moderado y el 2,15% severo, en el que están incluidas también las personas atendidas en los programas de negligencia, riesgo, aislamiento social y maltrato. En base a ello se establece la periodicidad de las llamadas de seguimiento, que refuerzan el vínculo con el servicio y aseguran la detección de necesidades sociales que la persona pueda expresar explícita o implícitamente durante las conversaciones mantenidas.

El servicio ofrece, además, la instalación en el domicilio de las personas usuarias que reúnen el perfil, de **dispositivos periféricos** con conexión directa con los centros de atención, que permiten la prevención de situaciones de riesgo. En los casos valorados con riesgo severo y moderado se ha ofrecido la instalación de dispositivos de gas y humo, si no los tenían previamente instalados o si los habían rechazado en visitas anteriores. En el resto de los casos en los que no existe riesgo social, se ha valorado e instalado estos dispositivos como medida preventiva cuando la situación lo requería. Durante 2022 han estado instalados 20.366 dispositivos periféricos en los domicilios de las personas usuarias, lo que supone un decrecimiento del 0,79% respecto al año anterior.

Asimismo, siguen aumentado las personas usuarias que se benefician de innovaciones tecnológicas más avanzadas, destinadas a atender a **personas con limitaciones auditivas y/o de habla**, con el fin de que éstas puedan beneficiarse de todas las prestaciones del servicio, así como de dispositivos más avanzados tecnológicamente y que suponen una **mejora ante las caídas** o accidentes en el domicilio a personas con antecedentes o riesgo de sufrir pérdidas de conocimiento. Los dispositivos periféricos generaron el 1,96% de las emergencias atendidas en el servicio.

En relación con las llamadas de emergencia, un año más destacan las situaciones de emergencia sanitaria, que representan un 75,60 %, del total de las emergencias recibidas. También se observa un incremento del 5,70% de las llamadas de emergencia social y el 30,03% de las emergencias por crisis de soledad, angustia y ansiedad.

En este sentido, durante 2022 se han realizado más de 5.045.355 millones de llamadas de seguimiento y atención personal a las personas usuarias del servicio, lo que representa el 42.97% del total de comunicaciones del servicio.

TRUJILLO FORMACIÓN

Otras actuaciones del Servicio de TAD.

a) Actuaciones con personas cuidadoras

El servicio de TAD no sólo presta atención a las personas usuarias del servicio, sino también a sus cuidadores. En 2022, valoraron a 867 personas cuidadoras, de cuales un 34,18% presentaron **sobrecarga.** El servicio, partiendo de este dato, ha desarrollado actuaciones específicas para abordarlo, entre las que destacan el seguimiento individual telefónico, actuaciones de intervención grupal de autoayuda, actividades formativas y la coordinación con los servicios sociales en aquellos casos donde se detectaron situaciones de fragilidad, vulnerabilidad y/o riesgo social.

Por otro lado, se ha puesto especial énfasis en la promoción de los recursos municipales que están a disposición de las personas cuidadoras como el **Programa "Cuidar a Quienes Cuidan"** y que tratan de forma específica algunas de sus problemáticas, para lo que se ha contado como en años anteriores con el equipo de coordinación, para detectar y derivar casos de aislamiento y soledad y para favorecer la participación en los distintos cursos y talleres ofrecidos para personas cuidadoras desde Servicios Sociales.

b) Programa de Telemonitorización

Este programa persigue potenciar modelos de atención y cuidados innovadores en el domicilio de las personas usuarias a través de dispositivos tecnológicos integrados en los sistemas de comunicación e información del servicio, permitiendo la identificación de situaciones que requieren **intervenciones de carácter sociosanitario**.

De la implantación de dichos dispositivos, un 131,97% más en 2022, cabe destacar el aumento de un 38% de soluciones tecnológicas relacionadas con el **seguimiento y control de las constantes biomédicas** para el seguimiento de **enfermedades crónicas** (patrón de vida, telemonitorización del ritmo cardiaco …).

d) Actuaciones específicas según riesgo social.

Dentro del servicio, un equipo interdisciplinar formado por profesionales de psicología/as, terapeutas ocupacionales, personal de enfermería, etc., realizan **actuaciones de apoyo y prevención en las áreas de vulnerabilidad y riesgo social, a través de llamadas y visitas domiciliarias**. A lo largo del año 2022 se han realizado un total de 224.133 actuaciones específicas.

Los casos de vulnerabilidad detectados, en los cuales el servicio hace un seguimiento intensivo, se coordinan con servicios sociales y con la Mesa de Vulnerabilidad; en 2022 se han coordinado 2.235 casos.

También asesoran a las personas usuarias o sus familiares ante problemas formulados, atienden alarmas de emergencia y situaciones de crisis de soledad/angustia/ansiedad y valoran la accesibilidad de la vivienda y entorno inmediato, asesorando sobre aquellos productos de apoyo que facilitan la autonomía personal y previenen el riesgo de caídas.

Además, para promover el envejecimiento activo y saludable se han realizado 12 **actividades socio culturales y de participación comunitaria, a través de talleres y visitas culturales**, destacando la incorporación de las mismas vías online, de las que se han beneficiado 118 personas.

e) Proyecto "conexión con SAD a través de TAD"

La mejora de la accesibilidad de los servicios para personas mayores y/o en situación de dependencia es una inquietud compartida por la Dirección General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid y las entidades prestadoras de los servicios municipales. Son numerosas las personas usuarias del servicio de teleasistencia que cuentan también con la prestación de ayuda a domicilio municipal. Por ello, se puso en marcha en junio del año 2021 este proyecto para coordinar ambos servicios en el que participaron 150 personas usuarias.

TRUJILLO FORMACIÓN

f) Proyecto de coordinación y colaboración con emergencias sanitarias 112 y centros de salud de atención primaria

Durante 2022 se han desarrollado reuniones de coordinación con profesionales del 112 y centros de salud de atención primaria, con el objetivo de mejorar la respuesta coordinada de la atención a las personas usuarias de Teleasistencia, en situación de urgencia/emergencia, desarrollando criterios de intervención y soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos sociosanitarios.

g) Nuevo contrato de servicio de teleasistencia

Durante 2022 se ha trabajado en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas, así como los criterios de adjudicación del nuevo contrato. Para ello se han mantenido numerosas reuniones de coordinación con las entidades de teleasistencia, empresas de tecnología relacionadas con el servicio y con profesionales de teleasistencia a nivel estatal y autonómico.

h) Proyecto Madrid contigo ante la soledad no deseada

El servicio, en coordinación con la Dirección General de Mayores lleva a cabo este proyecto dirigido a la prevención, detección y atención de la soledad y aislamiento no deseado en personas mayores de 65 años o menores de esa edad en situación de vulnerabilidad. Surge con la finalidad de **paliar el sentimiento de soledad no deseada de las personas mayores y contribuir al fortalecimiento del vínculo entre la persona y su entorno a través del trabajo en red.**

Para el abordaje de esta estrategia, participan en el proyecto tres asociaciones de voluntariado, "Solidarios para el Desarrollo", "Grandes Amigos" y "Nadie solo" que, a través de diferentes perspectivas y programas, contribuyen a reducir la soledad de las personas mayores derivadas desde el servicio de Teleasistencia. Entre ellos se encuentran: "Convive", "Acompañamiento presencial y telefónico", "Acompañamiento domiciliario" y "Grandes Vecinos".

CARTA DE SERVICIOS DE LA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

Fecha de aprobación.	10 de julio de 2.008.
Fecha de certificación.	23 de diciembre de 2.020.
Fecha de última evaluación	11 de marzo de 2.024.

Esta Carta de Servicios hace referencia al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (TAD). Es un **servicio social de atención y apoyo personalizado**, que permite a las personas usuarias disponer de una atención telefónica permanente, las 24 horas del día, todos los días del año. Profesionales con formación especializada y medios técnicos dan respuesta adecuada a las situaciones de necesidad social o de emergencia, incluida la movilización de otros recursos, si fuera necesario.

Sus **objetivos** son:

- Proporcionar compañía, seguridad y tranquilidad a la persona usuaria y a sus familiares.
- Favorecer su permanencia en el entorno familiar y social habitual.
- Incrementar la autonomía y calidad de vida de las personas a las que se dirige.

Esta Carta se alinea con los **Objetivos 1. Fin de la pobreza, 3. Sanidad y bienestar, 5. Igualdad de género, 11. Ciudades y comunidades sostenibles y 17.**

TRUJILLO FORMACIÓN

SERVICIOS PRESTADOS.

Atención y apoyo personalizado: atención a llamadas telefónicas y llamadas de seguimiento.	Las personas usuarias podrán ponerse en contacto con el personal especializado que atiende el servicio a través de: ▪ el dispositivo de teleasistencia conectado en su domicilio a una línea telefónica fija o móvil. ▪ la unidad de control remoto en forma de colgante o pulsera, con botón pulsador, que le han proporcionado. El personal especializado les ofrecerá una respuesta adecuada a la demanda planteada. Las llamadas de seguimiento podrán ser: ▪ llamadas periódicas, de acuerdo con el nivel de riesgo social, ▪ llamadas de cortesía, ▪ llamadas de mantenimiento de agenda (medicación, citas médicas).
Soporte técnico a los dispositivos.	▪ Dispositivo de Teleasistencia. ▪ Unidad de control remoto, de tipo colgante o pulsera. ▪ Otros dispositivos de tecnología avanzada, destinados a personas con especiales necesidades que sirven de apoyo en la prevención y detección de situaciones de riesgo: – Detector de gas. – Detector de humos. – Detector de caídas. – Detector de movimiento. – Dispositivo adaptado a problemas de audición o de habla.
Atención presencial en el domicilio.	Atención presencial ante situaciones de emergencia domésticas, psicosociales, sanitarias, etc., para su resolución. El servicio desplazará al domicilio a personal de apoyo, no sanitario, para atender la situación producida. El desplazamiento estará condicionado a la gravedad de la situación. Si es necesario se realizará la apertura de puertas. El servicio **no presta atenciones de carácter sanitario** (atención médica, manipulación de aparatos o instrumentos que precisen de conocimientos profesionales, que sean competencia de personal sanitario, traslado a centros de salud u hospitalarios y similares). Para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas usuarias, quienes acudan al domicilio estarán perfectamente **identificadas**, portando el logotipo del Ayuntamiento de Madrid en lugar bien visible.
Coordinación.	**Coordinar la actuación con otros servicios, en caso necesario, para dar una respuesta adecuada a la petición de ayuda:** Policía, Samur Social, 112, Bomberos, Centro de Salud, etc., y con otros recursos de carácter privado, en su caso.
Información y asesoramiento.	**Informar y asesorar** telefónicamente en materia económica, social, jurídica y psicológica por profesionales especializados para todas aquellas personas que lo soliciten.

TRUJILLO FORMACIÓN

Promoción del envejecimiento activo y saludable.	**Promover actividades que favorezcan el envejecimiento activo y saludable,** fomentando la participación en actividades culturales, lúdicas o de ocio, deportivas, talleres, y promoviendo las relaciones interpersonales y redes de apoyo.
Apoyo a las familias.	**Atender, orientar y apoyar al entorno sociofamiliar** que asume el cuidado de las personas usuarias del servicio.
Información.	Informar sobre el servicio de Teleasistencia y otras cuestiones relacionadas. También en los Centros de Servicios Sociales.
Sugerencias, felicitaciones y reclamaciones.	▪ Gestionar las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones remitidas por la ciudadanía. ▪ Informar sobre su estado de tramitación.
Personas destinatarias.	▪ Personas mayores de 65 años, priorizando a las mayores de 80 años que vivan solas. ▪ Personas de entre 18 y 64 años, en situación de dependencia reconocida por resolución administrativa del órgano competente, que incorpore el Servicio de TAD en su programa individualizado de atención (PIA). ▪ Personas de entre 18 y 64 años, en situación de riesgo de aislamiento severo (excepto situaciones que se atienden desde servicios especializados) o con enfermedad grave e incapacitante. El acceso al Servicio de estas personas deberá venir acompañado de informe de los Servicios Sociales que justifique tal necesidad.
Requisitos.	▪ Estar empadronado/a en la ciudad de Madrid. ▪ Disponer en el domicilio de línea telefónica. ▪ Tener capacidad la persona interesada, o en su caso la persona con la que conviva, para realizar un uso adecuado del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
Prestación del Servicio.	Para la prestación de la Teleasistencia Domiciliaria, el servicio cuenta con **diferentes perfiles profesionales:** ▪ La persona que ejerza las funciones de coordinación debe ser graduada en Trabajo Social o Terapia Ocupacional, ▪ El personal teleoperador debe contar con titulación de bachiller o equivalente, ▪ El personal encargado del asesoramiento y apoyo en las llamadas de emergencia deberá ser Graduado Universitario en Enfermería o en Psicología, ▪ El personal de la Unidad de Apoyo Domiciliario debe tener titulación de bachiller o equivalente y, por último, ▪ Las/os instaladoras/es deberán contar con la formación técnica adecuada. En la prestación del servicio estará **garantizada su continuidad en el tiempo**. Este no se suspenderá salvo deseo expreso de la persona usuaria, baja en el padrón municipal, cambio en las condiciones que motivaron la concesión, o incumplimiento de sus obligaciones.
Coste del Servicio.	La aportación de las personas usuarias al coste del servicio estará en función de la Renta Mensual Per Cápita (RMPC), es decir, de su capacidad económica. Se establece, por tanto, una **cuota única por** domicilio, independientemente del número de beneficiarios del servicio. El cargo se efectúa en los 10 primeros días del mes siguiente.

TRUJILLO FORMACIÓN

COMPROMISOS DE CALIDAD.

Compromiso 1.

Atendemos en menos de 1 minuto el 96% de las **llamadas al Servicio de Teleasistencia**. El **tiempo máximo** de respuesta es de 3 minutos.

Compromiso 2.

Acudimos al domicilio cuando la llamada es por un caso de **necesidad**, siempre que la persona usuaria esté sola o acompañada de alguien sin capacidad para resolver la situación.

Compromiso 3.

Comprobamos cada 15 días el **correcto funcionamiento de todos los dispositivos** de teleasistencia. Reparamos el 97% de las averías que impiden la comunicación en 48 horas o menos. El tiempo máximo de resolución de estas averías es de 3 días naturales.

Compromiso 4.

Llamamos al menos una vez a la semana a las **personas usuarias** de Teleasistencia que viven **solas**, **no salen del domicilio** habitualmente y cuentan **con escaso apoyo social**. El objetivo es llamar al 97% de estas personas dos o más veces a la semana.

Compromiso 5

Apoyamos a los **familiares** que presentan **sobrecarga** por los cuidados de las personas usuarias, con el fin de facilitarles ayuda con los recursos disponibles. Medimos el grado de sobrecarga del 97% de las personas cuidadoras familiares en 3 meses o menos. El tiempo máximo de valoración es de 6 meses.

Compromiso 6

Garantizamos que todo el **personal** que trabaja en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria recibe (salvo motivo de baja laboral o causas de fuerza mayor) una **formación** específica de al menos **7 horas anuales** para las funciones que realiza, siempre que su permanencia en el servicio sea igual o superior a un año.

Compromiso 7

Atendemos de forma **adecuada, amable y respetuosa** a las personas usuarias. El objetivo es que el 97% valore el trato recibido con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.

Compromiso 8

Prestamos el Servicio de Teleasistencia de forma que las personas usuarias estén **satisfechas** con el mismo. El objetivo es que el 96% de las personas usuarias valore el servicio con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10 y que al menos el 98% lo considere **recomendable** para otras personas.

Compromiso 9

Contestamos el 80% **de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones** como máximo en **30 días** naturales y en ningún caso en un plazo superior a 2 meses.

TRUJILLO FORMACIÓN

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO.

La Comida a Domicilio es una **prestación dirigida a personas mayores de 65 años que viven solas o con personas de similar o mayor dependencia, sin red de apoyo, que presentan dificultades a la hora de elaborar la comida o bien que tienen problemas de salud provocados por un déficit nutricional**.

También pueden ser beneficiarias del servicio **personas menores de 65 años que, por su especial situación de exclusión social o de dependencia y previo informe social** del distrito valorado por servicios técnicos municipales, así lo requieran.

El objetivo fundamental del servicio, es **proporcionar una dieta compensada y variada, previniendo situaciones de malnutrición en las personas mayores y personas con discapacidad**. En este sentido se cuenta con una variedad de menús que abarcan diversas patologías que puedan presentar las personas usuarias.

Para acceder al servicio, todas las personas solicitantes son valoradas conforme al **perfil de riesgo valorado por su trabajador/a social,** en base al cual se determina la frecuencia del seguimiento. También se contempla la entrega, en el caso de que se requiera y no se disponga de los mismos, de **microondas y frigoríficos** para las personas usuarias, en régimen de préstamo, durante su prestación.

El contrato del servicio se inició 1 de diciembre de 2021, con una vigencia de tres años, donde se incorporaron novedades y mejoras importantes, como la introducción de cambios en el menú basal (menú básico del servicio). Este ha sido diseñado de forma que se favorezca una dieta mediterránea apta para la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas evitables más frecuentes, debidas al consumo elevado de sodio, azúcares, grasas y a la ingesta insuficiente de cereales integrales, legumbres, frutas y hortalizas, por lo que es bajo en sal, en grasas saturadas, azúcares y ácido úrico e hipocalórico. Esta adaptación permite, además, evitar la denegación del servicio por incompatibilidad si se sufren pluripatologías (diabetes, sobrepeso, ácido úrico o tratamiento con Sintrom).

Todos los menús podrán ser presentados en **formato normal, fácil masticación o triturado**. En relación con la comida triturada, con el fin de romper la monotonía que supone para las personas usuarias el consumo de todos los platos en ese formato, existen ocho platos en formato texturizado y tres postres en formato mousse. La asignación del menú adecuado a la situación de la persona usuaria viene acreditada mediante informe médico, que determina el tipo de dieta adecuado a sus diferentes patologías.

La importancia de la prestación se ha ido poniendo de relieve en los últimos años. En el año 2022, con respecto al año 2021, hemos experimentado un crecimiento con relación al número de personas usuarias de un 8,80%. En este sentido, cabe destacar que el 78% de las personas atendidas se ha incorporado al servicio en los últimos 3 años.

Si analizamos el perfil de las personas usuarias del servicio, observamos cómo la media de edad es de 82 años. Es importante destacar que las personas usuarias mayores de 80 años que viven solas ascienden a 1.856, suponiendo un 60,85% del total. Este dato es fundamental a la hora de realizar un mayor seguimiento de estos casos y de diseñar actividades enfocadas a evitar su aislamiento y la soledad.

Además, durante 2022 se ha atendido a 422 personas menores de 65 años, debido a su situación de elevado riesgo social, enfermedad mental, discapacidad intelectual, discapacidad física o con una enfermedad terminal. Este colectivo, representa actualmente un 8,25% del total de personas usuarias atendidas por el servicio.

Con relación al grado de dependencia, y en base a los datos obtenidos del BSN, el grupo mayoritario de personas usuarias se encuentra en un nivel de dependencia asimilable al Grado I de dependencia.

Perfil de la persona usuaria: mujer que vive sola, con más de 82 años, con una dependencia moderada y con una RMPC de 699,50 €.

Reseñar que existe la posibilidad de servir cenas para aquellas personas que, por sus circunstancias especiales y previo informe social, lo necesiten. En este año sólo 45 personas han contado con el servicio.

TRUJILLO FORMACIÓN

Los repartos del Servicio se realizan en horarios de mañana y tarde, de lunes a viernes. En 2022, el 7% de las personas usuarias tuvo reparto 3 días a la semana, el 17% 2 días a la semana, y el 76% 1 día a la semana.

Cabe destacar como prestaciones complementarias más importantes: la cesión de 358 microondas y 60 frigoríficos, la elaboración de menús especiales en fiestas señaladas y cumpleaños, la entrega de pequeños obsequios en Navidad y el envío del menú mensual por mail a 787 familiares de persona usuarias, entre otras.

OTRAS PRESTACIONES.

Proyecto de detección de casos en situación de aislamiento o fragilidad social.

En aquellos casos en los que existe la sospecha, por parte de la coordinadora de referencia, se realizará un seguimiento especial del caso en coordinación con otros recursos de ayuda a domicilio y de la Mesa de Vulnerabilidad. Actualmente están incluidos en el proyecto de fragilidad social, 30 personas y en situación de aislamiento, a 27 personas usuarias.

Siguiendo la línea de acción de dar un enfoque más integral y preventivo a la intervención con la persona mayor dentro del servicio, y más allá de las actividades socioculturales llevadas a cabo, destacan:

Biblioteca a Domicilio

Con la disponibilidad de 602 libros para las personas usuarias del servicio. A través del auxiliar de intervención, se realizan las peticiones y préstamos de los libros. A partir de julio de 2021 se ha incorporado a la biblioteca, una colaboración especial con la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, que facilita el préstamo de libros, que serán entregados a la persona usuaria, a través del auxiliar de intervención.

Certamen "La Mejor Receta"

Con la entrega por parte de las personas usuarias de su receta preferida y la posterior publicación de la ganadora y entrega al resto de las personas usuarias en el menú mensual del mes de noviembre de 2022.

Homenaje "Toda una vida"

Cuyo objetivo es homenajear a aquellas personas del servicio de comida a domicilio que cumplen 100 años. Este año han cumplido 100 años, dos personas usuarias del servicio, entregándole un pequeño obsequio y un cartel conmemorativo.

Asimismo, además de un mayor seguimiento de las personas usuarias del servicio a través de visitas domiciliarias y contacto telefónico, se ha introducido un **Servicio de Orientación Nutricional** y la creación de una APP para favorecer la comunicación y la gestión del servicio, dirigidos ambos, tanto a la población receptora como a sus familiares.

SERVICIO DE PRODUCTOS DE APOYO.

El servicio se viene prestando desde el año 2007, en el marco del programa de Atención a las Personas Mayores del Ayuntamiento de Madrid, como **recurso técnico que proporciona productos de apoyo (en adelante, PA) para garantizar la permanencia de la persona usuaria en el hogar el mayor tiempo posible y en las debidas condiciones de seguridad, favoreciendo su cuidado, su movilidad y trasferencias; mejorando así su calidad de vida y la de sus cuidadores**.

TRUJILLO FORMACIÓN

Este nuevo contrato ha incorporado novedades y mejoras importantes, entre ellas, la sustitución de todos los productos de apoyo instalados en los domicilios por productos nuevos, además de incrementar el número de productos de apoyo del servicio, sobre todo grúas en un 30%. Así mismo, el servicio ofrece distintas opciones de cada tipo de producto, que se adaptan a las diversidad de necesidades de las personas usuarias del servicio y a su perfil cambiante: camas extra bajas, bariátricas (obesidad), estándar; grúas geriátricas de tamaño más reducido, más adecuadas para uso en el domicilio, de 150Kg y 175kg.; y una gran variedad de arneses, que se adaptan a las necesidades de cada persona usuaria (amputados, control cefálico, estándar, tallas..), evitando así denegaciones de servicio por incompatibilidad con el producto ofertado.

La prestación está dirigida a personas mayores de años 65 que presentan tal grado de limitación funcional (grave/total), que les obligue a mantenerse encamado por periodos prolongados o permanentemente, y que además cumplan alguna de las siguientes condiciones, en función del producto de apoyo solicitado:

Para cama articulada:

• Que presenten gran limitación funcional en miembros inferiores.

• Que permanezcan la mayor parte de los días encamados.

• Que el aseo deba ser realizado en la cama.

• Para grúa geriátrica

• Que presenten gran limitación funcional en miembros inferiores.

• Que no colaboren en las trasferencias corporales.

• Que no tengan control de tronco.

El servicio proporciona los siguientes tipos de productos:

• **Camas articuladas**: se ofrecen a personas que deben permanecer encamadas, facilitando el aseo personal, la ingesta de alimentos y los cambios posturales y reduciendo la posibilidad de que aparezcan lesiones dérmicas (escaras).

• **Grúas geriátricas domiciliarias**: favorecen la movilización y traslado de personas con movilidad reducida.

Además, el servicio ofrece el mantenimiento y reparación de las averías de los productos de apoyo, así como la valoración del nivel de dependencia de la persona usuaria (previa a la instalación), el adiestramiento sobre el manejo y uso de los productos, y visitas domiciliarias anuales para el seguimiento tanto de la persona usuaria como del estado de los productos; así como llamadas semestrales.

Durante 2022, se prestó el servicio a 903 personas, un 6.61% más que en 2021, debido al aumento del número de productos de apoyo y a una mayor rotación de los productos de apoyo, ante el crecimiento de bajas de las personas usuarias y de altas como consecuencia de esto.

La media de edad de los usuarios atendidos en el servicio es de 87,28 años. Es importante destacar que el 82,39% (60.58% mujeres) de las personas usuarias del servicio tienen más de 80 años, y, el 46,84% (36,77% mujeres) de 90 años. Esto nos indica el sobre envejecimiento progresivo de la población que atendemos y de la situación de los cuidadores/ familiares directos, mayores de 65 años en un alto porcentaje.

En relación con el grado de dependencia, en base a los datos obtenidos de la escala Barthel, el 80,8% presentan un nivel de gran dependencia o dependencia total para las actividades de la vida diaria (asimilable al Grado III de dependencia); Es importante subrayar que el 65% de estos, tienen más de 80 años y viven solos, apoyados en un alto porcentaje por el servicio de SAD; por lo que debemos tener en consideración la situación de vulnerabilidad y riesgo social en la programación de actuaciones específicas para los mismos.

Perfil de la persona usuaria: mujer con más de 85 años, que vive acompañada, con una a gran dependencia funcional (total / grave) y con una RMPC de 887,10 €

TRUJILLO FORMACIÓN

SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIARIA MUNICIPAL.

El Servicio de Lavandería Municipal incluye la **recogida, tratamiento y posterior entrega en el domicilio de las personas usuarias de ropa de hogar y personal, lavada y planchada.**

Está dirigido a personas mayores de 65 años, empadronadas en el municipio de Madrid. Podrán ser usuarias de este servicio aquellas personas que presentan un estado físico o psíquico tal, que les impida o dificulte la realización de las actividades de la vida diaria, tales como tareas de lavado, secado o planchado de ropa, o bien que no dispongan de los medios adecuados en su domicilio, de espacio, y medios económicos para su instalación. El servicio también está dirigido a personas menores de 65 años, discapacitados o dependientes, que se encuentran en situación de grave riesgo o exclusión social, situación valorada previamente por los/as trabajadores/as sociales de los Centros de Servicios Sociales.

Asimismo, este Servicio se constituye como un gran apoyo a los cuidadores de personas dependientes, facilitándoles la limpieza de la ropa de cama y personal de la persona usuaria, para evitar la sobrecarga en los cuidados.

Cabe destacar que, aparte del lavado ordinario de ropa personal y el lavado anual complementario de ropa de hogar de la persona usuaria, el servicio realiza, como prestación extraordinaria, el tratamiento de ropa con infestaciones de vectores en aquellos domicilios en los que se presenta esta circunstancia, siendo necesario un procedimiento específico en la manipulación y el lavado de la ropa.

A diferencia de otros servicios de ayuda a domicilio, las personas usuarias de lavandería son en su mayoría hombres, mayores de 80 años, que viven solos, con dependencia funcional leve o moderada, en situación de riesgo social y precariedad socioeconómica. Cabe destacar que el 21,71% de personas usuarias son menores de 65 años, en situación de gran vulnerabilidad y que requieren un seguimiento mayor por parte del servicio, ya que en muchos casos es el único recurso que aceptan por parte de los servicios sociales.

Perfil de la persona usuaria: hombres, mayores de 80 años que viven solos, con dependencia funcional leve o moderada, en situación de riesgo social y precariedad socioeconómica.

Por último, cabe destacar el objetivo integrador que tiene la prestación de este servicio respecto al personal que lo presta, ya que se trata de una empresa de inserción social, cuyo personal ha sido derivado por su centro de servicios sociales y entidades del tercer sector, consiguiendo a través de este contrato su inserción laboral a través de un contrato estable.

4.3.- CENTROS DE DÍA.

Los Centros de Día son **equipamientos no residenciales de los servicios sociales municipales donde se presta atención socio-sanitaria, preventiva y rehabilitadora al colectivo de mayores, en régimen diurno**.

Son objetivos principales de estos centros: **proporcionar atención socio-sanitaria que prevenga y/o compense la pérdida de autonomía, facilitar la permanencia en su medio habitual, retrasar la institucionalización a aquellos casos en situaciones límite y con grave deterioro físico y/o cognitivo. Además, facilita apoyo a los familiares y/o personas cuidadoras principales de la persona mayor**.

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 4.719 plazas, repartidas en **65 Centros de Día Municipales** (3.355 plazas) y **35 Centros de Día Privados con plazas financiadas** (1.364 plazas).

TRUJILLO FORMACIÓN

CENTROS.	Municipales.	Privados.	Totales.
	65	**35**	**100**
Físicos.	36	6	42
Alzheimer.	29	29	58
Nº plazas disponibles.	3.355	1.345	4.700

De las 5.459 personas usuarias atendidas en centros de día y residencias, 4.520 son personas dependientes, con Programa Individual de Atención (PIA) de centros de día (CD), pero no todas han podido ser atendidas a cargo de la financiación del convenio de Dependencia de la Comunidad de Madrid. Esto supone un 82,80% de personas usuarias totales.

Se produce un incremento en el número de personas a atender a cargo de la financiación del convenio de Dependencia de la Comunidad de Madrid, pasando de un 71,57% en el año 2021 a un 82,80% en el año 2022 (aumento de 11,23%).

CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DÍA.	
Fecha de aprobación.	8 de abril de 2.010.
Fecha de última evaluación	11 de marzo de 2.024.

Esta Carta de Servicios hace referencia a los **Centros de Día**, tanto municipales, como privados con plazas financiadas por el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid dispone de 90 Centros de Día distribuidos por los diferentes distritos de la ciudad.

Son **equipamientos de servicios sociales no residenciales dirigidos a proporcionar una atención sociosanitaria integral, en régimen diurno:**

1.º Para acceder a centros de día, para personas mayores con deterioro físico o relacional, tener cumplidos 60 años y estar afectados por un deterioro físico o relacional, que haga aconsejable su atención en un centro.

2.º Para acceder a centros de día, para personas con deterioro cognitivo tipo enfermedad de Alzheimer u otras demencias, tener cumplidos 60 años, padecer la enfermedad tipo Alzheimer u otras demencias y presentar una situación que haga aconsejable su atención en un centro especializado.

3.º Excepcionalmente, podrán acceder a estos centros personas menores de 60 años cuando se encuentren en una situación que aconseje este recurso, previo el correspondiente informe de los servicios sociales municipales.

Su objetivo es prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía, facilitando apoyo a los familiares o personas cuidadoras.

Se pretende lograr el mantenimiento de las personas usuarias en su medio habitual, retrasando o evitando el ingreso en un Centro residencial, mediante una atención basada en los principios del modelo de **Atención Centrada en la Persona**, respetando su dignidad, autonomía e independencia y promocionando la realización de actividades significativas y con sentido para la persona.

Esta Carta se alinea con los **Objetivos 1. Fin de la pobreza, 3. Sanidad y bienestar, 5. Igualdad de género, 11. Ciudades y comunidades sostenibles y 17. Alianzas para alcanzar los objetivos** como base para la consecución del resto de objetivos.

TRUJILLO FORMACIÓN

SERVICIOS PRESTADOS.

Atención social, sanitaria, preventiva y rehabilitadora.	▪ Acoger en el centro e informar del funcionamiento del mismo. ▪ Realizar una valoración integral de la situación personal y familiar. ▪ Elaborar un Plan de Atención Personalizado (PAP), consensuado con la persona usuaria y/o con su familia. ▪ Detectar situaciones de riesgo sociosanitario. ▪ Hacer seguimiento de las patologías crónicas (diabetes, hipertensión arterial). ▪ Realizar educación para la salud. ▪ Realizar fisioterapia grupal. ▪ Entrenar para las actividades de la vida diaria. ▪ Entrenar para las capacidades intelectuales (memoria, atención...). ▪ Dar apoyo, información y asesoramiento social sobre otros recursos que permitan mejorar la atención de la persona usuaria. ▪ Realizar actividades culturales, recreativas y de relación social. ▪ Hacer seguimiento de la evolución de la persona usuaria.
Apoyo a la familia.	▪ Apoyar el proceso de cuidado y atención que presta la familia o la persona cuidadora. ▪ Realizar actividades formativas e informativas sobre temas vinculados a la atención que se presta en el Centro de Día. ▪ Ofrecer a la familia la posibilidad de participar en las actividades del Centro (fiestas, celebraciones, excursiones…). ▪ Promover la participación en los programas municipales de atención a la familia: "Respiro Familiar" y "Cuidar a Quienes Cuidan".
Aseo y cuidado personal.	▪ Ayudar en el aseo y cuidado personal siempre que se necesite, velando y respetando siempre la privacidad y potenciando la autonomía. Todos los Centros de Día disponen de aseos adaptados y baños geriátricos para facilitar el adecuado servicio de aseo y cuidado personal.
Alimentación y nutrición.	▪ Proporcionar desayuno, comida y merienda, adaptados a las necesidades nutricionales, con menú ordinario y, en caso necesario, dietas especiales (sin sal, para personas diabéticas y celiacas, astringente, triturada, etc.). Todos los menús están supervisados por un profesional de medicina o nutricionista.
Transporte adaptado.	▪ Realizar el traslado en vehículo desde el portal de su domicilio hasta el Centro de Día y viceversa de las personas usuarias que lo demanden y dentro del horario establecido. ▪ Ayudarles a subir, bajar y a situarse en el vehículo. Todos los vehículos destinados al traslado de las personas usuarias de todos los Centros de Día están adaptados para facilitar el acceso a los mismos y para garantizar su seguridad durante el trayecto.

TRUJILLO FORMACIÓN

Control y seguridad.	▪ Establecer las medidas de control necesarias, en aquellos casos en que puedan preverse situaciones de riesgo para las personas usuarias, informando de las mismas a sus familiares o personas cuidadoras principales. Todos los Centros de Día especializados en personas con deterioro cognitivo cuentan con medidas de seguridad en las puertas de acceso (sistema de control electrónico) para la protección de las personas usuarias.
Información.	▪ Informar sobre la situación de los Centros y otras cuestiones relacionadas. Se encuentra en el siguiente vínculo Centros de Día del Ayuntamiento de Madrid. También en los Centros de Servicios Sociales y en los propios Centros.
Sugerencias, felicitaciones y reclamaciones.	▪ Gestionar las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones remitidas por la ciudadanía. ▪ Informar sobre su estado de tramitación.

El **acceso a estos servicios** se solicita en los Centros de Servicios Sociales de la ciudad de Madrid.

El trabajador/a social del Centro de Servicios Sociales correspondiente al domicilio de la persona solicitante, realizará un **estudio previo** de sus necesidades individuales y comprobará el cumplimiento de los requisitos necesarios, para derivarle al Centro que mejor se adecue a sus circunstancias.

Todos los Centros de Día contarán con un **equipo multidisciplina**r, con la titulación exigida para el desempeño de sus funciones. El equipo estará formado por profesionales de Trabajo Social, con funciones de Director/a, de Enfermería, de Fisioterapia, de Terapia Ocupacional, Auxiliares de Geriatría y en los Centros de Día especializados en personas con deterioro cognitivo tendrán además un profesional de la Psicología.

Para el servicio de transporte contarán además con conductor y auxiliar de ruta.

Personas destinatarias.	Los servicios están dirigidos a proporcionar una atención integral, en régimen diurno, a las personas mayores de 60 años y sin límite de edad, para las personas con deterioro cognitivo.
Requisitos.	- Tener nacionalidad española, ser residente comunitario o tener permiso de residencia. - Estar empadronada la persona interesada en el municipio de Madrid. - No padecer enfermedad infecto-contagiosa activa. - Presentar algún tipo de deterioro físico o relacional o deterioro cognitivo que haga aconsejable su asistencia a un Centro de Día y cuyas capacidades permitan su traslado a las dependencias del Centro. - No padecer trastornos mentales o de conducta que dificulten gravemente la convivencia en el Centro, ni cualquier otra enfermedad que requiera atención en un centro hospitalario. **El servicio se suspenderá** por deseo expreso de las personas usuarias, baja en el padrón municipal, cambio o pérdida de las condiciones que motivaron su concesión, no superar el periodo de adaptación o por incumplimiento de sus obligaciones.
Coste del Servicio.	La persona usuaria participa del coste de los servicios del Centro de Día, que variará en función de los días de asistencia y de si utiliza o no transporte adaptado, y de su capacidad económica.

TRUJILLO FORMACIÓN

El **horario de los Centros de Día** es, con carácter general, de lunes a viernes de 8:15 a 18 horas. Las personas usuarias podrán entrar en los Centros entre las 8:15 y 11 horas y salir entre las 16:30 y 18 horas.

Las personas que lo demanden podrán flexibilizar el horario de entrada o salida, garantizando que su permanencia en el Centro de Día le permita hacer uso y aprovechar las actividades que en él se ofertan. La disminución en el horario por flexibilidad no tendrá repercusión en la aportación de la persona usuaria.

El **servicio de transporte** podrá ser utilizado en las franjas horarias de entrada y salida. En los casos de flexibilidad horaria, el transporte no puede garantizarse.

COMPROMISOS DE CALIDAD.

Compromiso 1. Atendemos a las personas usuarias acorde a sus necesidades y deseos, para lo cual elaboramos, para cada una de ellas, un **Plan de Atención Personalizado (PAP)**. El objetivo es que el 100% lo tenga elaborado en los 45 días siguientes a su incorporación al Centro de Día y revisar el Plan al menos cada seis meses.
Compromiso 2. Ofrecemos unas **actividades y servicios adecuados a los deseos y capacidades** de las personas usuarias y cuidadoras. El objetivo es que el 85% los valore con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 3. Atendemos de forma **adecuada, amable y respetuosa** a las personas usuarias y cuidadoras. El objetivo es que el 93% valore el trato recibido con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 4. Realizamos una **planificación anual de actividades** para las familias. El objetivo es conseguir que el 92% de los familiares las valore con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 5. Contamos con **espacios adecuados y confortables**. El objetivo es que el 90% de las personas usuarias y cuidadoras los valore con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 6. Prestamos el servicio en un **horario** amplio y adaptado a las necesidades de las personas usuarias y cuidadoras. El objetivo es que el 90% lo valore con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10.
Compromiso 7. Prestamos un **servicio de calidad** de forma que las personas usuarias y cuidadoras estén **satisfechas** con el mismo. El objetivo es que el 93% lo valore con una puntuación igual o superior a 7, en una escala de 0 a 10, y que al menos el 96% lo considere **recomendable** para otras personas.
Compromiso 8 Contestamos el **60% de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones** como máximo en **30 días** naturales y en ningún caso en un plazo superior a 2 meses.

TRUJILLO FORMACIÓN

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL NEUROCOGNITIVA.

La pérdida de autonomía, a causa del deterioro cognitivo, no solo se produce en personas mayores, a veces comienza en edades más tempranas. En la atención al deterioro cognitivo de inicio precoz, la red de centros de día cuenta con el **Centro Municipal de Atención Integral Neurocognitiva (CMAIN) "Doctor Salgado Alba", cuyo objetivo es proporcionar las terapias y los medios necesarios para mantener las capacidades funcionales y cognitivas** el mayor tiempo posible de personas con **edades comprendidas entre los 30 y los 65 años, dando cobertura a todo el municipio de Madrid.**

Este Centro, pionero en todo el territorio español, ofrece un servicio con actividades y terapias adaptadas a la edad de las personas con deterioro cognitivo de inicio temprano que probablemente tendrían dificultades para adaptarse a Centros de día para personas mayores.

Se cuenta también con la posibilidad de ofrecer atención puntual de determinadas disciplinas en la unidad de atención ambulatoria para que las personas que lo soliciten puedan beneficiarse de sesiones semanales adaptadas a sus necesidades sin necesidad de permanecer toda la jornada en el Centro.

Además, se dispone de la posibilidad de organizar salidas y actividades de ocio en fin de semana.

ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA.

Por otro lado, retomando la actividad habitual de los centros, destacamos la realización de las actividades intergeneracionales de manera presencial, con un total de 539 actividades programadas anualmente entre los diferentes centros. De estos encuentros intergeneracionales, un total de 392 han sido diseñados de manera conjunta con las personas usuarias teniendo en cuenta sus preferencias y los acontecimientos más destacados recogidos en sus Historia de Vida.

En este año se ha dado prioridad a la realización de salidas programadas para disfrutar de actividades socioculturales realizándose un total de 230 salidas. Otras actividades que queremos destacar son las actividades que han realizado las personas usuarias junto con sus familias, este año se han realizado un total de 154 actividades en todos los centros de la red.

4.4.- ATENCIÓN A QUIENES CUIDAN.

Todos los programas y servicios apoyan a **las familias cuidadoras**, algo fundamental por ser conscientes de que, en no pocas ocasiones, el cuidado puede llevar aparejada una sobrecarga de diferente naturaleza, pero ante todo emocional.

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA PERSONAS CUIDADORAS.

El día 4 de noviembre, con motivo del Día Internacional de las personas cuidadoras, la Dirección General de Mayores ha presentado en el Palacio de Cibeles, la Estrategia para Familias Cuidadoras, aunando en la misma las líneas de intervención para detectar, paliar y abordar la sobrecarga de las familias que se ocupan de las personas mayores o con discapacidad de su entorno

Esta estrategia cuenta con 6 ejes (1.- Sensibilización y reconocimiento; 2.- Información; 3.- Asesoramiento global; 4.- Descarga de cuidados (atención a las personas mayores necesitadas de cuidados); 5.- Formación en cuidados y 6.- Atención psicoterapúetica y socializadora), con sus correspondientes medidas.

TRUJILLO FORMACIÓN

PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN. Intervención grupal.

Se trata de un **programa multimodal, psicoterapéutico, educativo y de autoayuda, dirigido a cuidadores y cuidadoras principales de personas mayores, así como a personas mayores cuidadoras de personas dependientes** (sea cual sea su edad y el tipo de dependencia funcional o/y psíquica, que vivan en su domicilio o en el de quienes les cuidan).

Este programa tiene por objeto la prestación de un servicio de valoración, asesoramiento e intervención psicoterapéutica y educativa para aliviar la carga del cuidado y mejorar la calidad de vida de la persona cuidadora y la necesidad de cuidados, favoreciendo la permanencia de la persona mayor en su domicilio, en las mejores condiciones posibles.
Así, el programa adquiere un carácter preventivo de trato inadecuado a la persona dependiente y de aislamiento social de quienes cuidan.

Para ello, el programa ha previsto la realización de actividades de prevención selectiva e indicada, a través de sesiones grupales de distinto contenido, visitas domiciliarias y llamadas telefónicas que se desarrolla durante todo el año.

En cuanto a los talleres grupales, se distribuyen los diferentes tipos de sesiones en dos ediciones anuales, con sesiones de una hora y media de duración, comenzando con las sesiones psicoterapéuticas y las mixtas. Posteriormente se realizan las educativas, dejando para el final las sesiones antiestrés y las de acompañamiento, realizándose un total de 18 sesiones en cada una de las ediciones, y llevándose a cabo en los 21 distritos municipales, que se van intercalando según cada situación. En ellos se abordan la sobrecarga de la persona cuidadora, diversos aspectos más relacionales, sesiones de carácter educativo para abordar problemáticas del cuidado, sesiones antiestrés para fomentar el optimismo y empoderamiento y sesiones de acompañamiento para dar continuidad al programa, lo que ha supuesto una clara mejoría con respecto al anterior contrato.

El programa está diseñado para atender a personas cuidadoras con sobrecarga moderada o severa en las sesiones psicoterapéuticas y mixtas o socializadoras dirigidas por profesionales de psicología. Las sesiones educativas, antiestrés y acompañamiento están destinadas a brindar herramientas en el cuidado, fomentar el optimismo y empoderamiento, así como a dar continuidad al programa creando grupos de autoayuda autogestionados. Todas estas sesiones son dirigidas por diferentes profesionales en función del contenido de éstas. A estas sesiones le siguen dos sesiones de mejora, realizando actividades de socialización presencial y dos sesiones de socialización digital con contenidos adecuados a las necesidades del grupo.

PROGRAMA "CUIDAD A QUIENES CUIDAN". Intervención individual.

El programa, además, cuenta con visitas domiciliarias por parte de profesionales adscritos al mismo, para que puedan comprobar in situ la situación de las personas cuidadoras de personas dependientes, con el objeto de mejorar la adaptación del programa y poder detectar situaciones de necesidad que no estén bien cubiertas o situaciones de vulnerabilidad.

Se realizan en el domicilio, al ser este el entorno más próximo a la persona cuidadora y la persona necesitada de cuidados y se valoran las circunstancias en que se lleva a cabo esta relación de cuidados. Además, en estas visitas se valora la sobrecarga de la persona cuidadora, las necesidades de la persona necesitada de cuidados, los apoyos con los que cuenta y se realiza la valoración de la vivienda.

También se ha incluido en el programa la intervención telefónica que se realiza para captación, seguimiento e intervención relacionada con las actividades grupales de cara a conseguir la adherencia a los grupos o la incorporación a éstos.

TRUJILLO FORMACIÓN

Aunque la vía de incorporación al programa sigue siendo mayoritariamente a través de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria (53%), cabe señalar el auge del teléfono específico del programa (17%) y las inscripciones en la web municipal (18%), dos vías en las que es la persona cuidadora quien demanda la participación de primera mano. Además, hay que añadir a estas vías las derivadas de la captación de las personas usuarias carentes de servicios municipales y que son perceptores de la Prestación Económica para cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) como ayuda de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (9%), a las que se remitió una carta informativa sobre el programa en el último trimestre del año.

Las personas que participan en las sesiones psicoterapéuticas son mujeres en el 70% de los casos (esposas e hijas). Los varones cuidadores representan el 30% y son mayoritariamente cónyuges. La edad media es de 67 años.

Las personas cuidadoras, en más del 66% de los casos, atienden a mayores dependientes que sufren demencia. El 40%% cuida a la persona mayor en soledad. Las personas cuidadas son dependientes en la práctica totalidad de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD).

Se han estudiado las repercusiones que a nivel socio familiar ha tenido el programa evaluando el impacto que este ha tenido sobre aspectos cotidianos, sociales y familiares en la vida del cuidador. Se utilizan variables de relación social y familiar, así como de petición y aceptación de ayuda.

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR.
Es un **programa social que se desarrolla en Centros de Día y Residencias de titularidad municipal, a través de un conjunto de actividades, durante los fines de semana (sábado y/o domingo), en régimen diurno no residencial**. Cuyos objetivos son: • Facilitar descanso a aquellas familias que tienen a su cargo a personas mayores dependientes. • Apoyar a las familias y /o personas cuidadoras. • Proporcionar la guarda del mayor durante el horario que permanece en el servicio. Ofrece diferentes servicios, como son: transporte adaptado, alimentación y nutrición, aseo y cuidado personal y atención socio-sanitaria.

4.5.- SERVICIOS RESIDENCIALES.

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con:

- **Dos residencias de atención a personas con deterioro cognitivo Alzheimer: Centro Integrado Jazmín y Centro Integrado Margarita Retuerto.**
- **Una residencia de atención a personas con deterioro perfil físico: Residencia Santa Engracia.**

Centro Integrado Jazmín.	El Centro Integrado Jazmín se encuentra ubicado en el distrito de Ciudad Lineal. Se compone de un área residencial y un área de Centro de Día con una capacidad de atención para 98 personas, simultáneamente.

TRUJILLO FORMACIÓN

	En el área residencial se atiende a 58 usuarios, y en el centro de día a 40. La residencia para enfermos de Alzheimer Jazmín es un equipamiento destinado al alojamiento y atención de aquellas personas que precisan de asistencia continua en la realización de las actividades de la vida diaria, al encontrarse afectados por la enfermedad de Alzheimer y/o otras demencias. Si bien el Centro es de titularidad municipal, la entidad que lo gestiona actualmente es ASISPA mediante contrato administrativo para la prestación del servicio público en la modalidad de concesión.
Centro Integrado Margarita Retuerto.	El Centro Integrado Margarita Retuerto se encuentra ubicado en el distrito Salamanca. Se compone de un área residencial y un área de Centro de Día con una capacidad de atención simultánea para 155 personas. En el área residencial se atiende a 90 personas aquejadas de Alzheimer y/o otras demencias: 80 plazas fijas, más 10 plazas más que se reservan para situaciones de emergencia entre personas mayores que precisen de solución residencial, a cuyo efecto se encuentran a disposición del Departamento de SAMUR SOCIAL y Personas sin Hogar del propio Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. De titularidad municipal, el centro es gestionado por la entidad ASISPA asimismo, mediante contrato administrativo para la prestación del servicio público en la modalidad de concesión.
Residencia Santa Engracia.	El Centro Integrado para personas mayores Santa Engracia está situado en la plaza Descubridor Diego de Ordás, en el distrito Chamberí. El centro se compone de un Centro de Día con capacidad para 45 usuarios y un área residencial con capacidad para 36 usuarios en habitaciones dobles, (26 plazas fijas), y 10 plazas para situaciones de emergencia social, a cuyo efecto se ponen igual que en el caso de la Residencia Margarita Retuerto, a disposición del Departamento del Samur Social y Personas Sin Hogar. La entidad EULEN gestiona el Centro Integrado Santa Engracia, mediante un contrato administrativo para la prestación del servicio público, en la modalidad de concesión.

4.6.- SITUACIONES DE DEPENDENCIA.

La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, promueve que las personas en situación de dependencia sean atendidas, fundamentalmente desde los ámbitos, autonómico y local.

Por ello, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento vienen suscribiendo un Convenio de Colaboración para la atención a las personas en situación de dependencia.

Los distritos que más solicitudes registran son Puente de Vallecas, seguido por Latina y Carabanchel.

Las solicitudes enviadas a la Comunidad de Madrid se acompañan, del correspondiente Informe Social de Dependencia, elaborado por las/los trabajadoras/es sociales municipales. Durante el año 2022, se realizaron 12.280 informes sociales.

En lo que respecta al perfil de las personas solicitantes, hay que constatar que mayoritariamente se trata de mujeres, siendo el grupo mayoritario, personas de mayores 80 años.

El procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia incorpora otros posibles trámites, como son el de revisión del programa individual de atención y la solicitud de aplicación del trámite de urgencia.

TRUJILLO FORMACIÓN

Durante el año 2022, el Departamento de Planificación de la Atención Social Primaria ha revisado y gestionado 11.636 revisiones de PIA, remitidas desde los centros de Servicios Sociales.

La normativa contempla que por razones de interés público se pueda solicitar la aplicación del trámite de urgencia. Durante el año 2022 fueron gestionadas un total de 1.993 peticiones de aplicación del trámite de urgencia.

4.7.- MAYORES VULNERABLES.

La detección de personas mayores vulnerables es fundamental para evitar las situaciones funestas que esta situación puede comportar.

LA MESA DE VULNERABILIDAD.

La Mesa de Vulnerabilidad está formada por un equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito social y sanitario del Departamento de Programación, Evaluación y Desarrollo adscrito a la Dirección General de Mayores, donde se realizan reuniones semanales para valoración de todos los casos recibidos desde los diferentes servicios, y cuyo objetivo es detectar y valorar situaciones de personas mayores vulnerables o potencialmente vulnerables, para paliar y evitar éstas.

La metodología de trabajo es:

• Detección: screening emergencias / apertura puerta de bomberos.

• Valoración de los casos recibidos en Mesa de Vulnerabilidad.

• Intervención general: Derivaciones informadas a servicios sociales de distrito /derivaciones a Voluntariado/ Derivaciones a otros servicios.

• Seguimiento de casos.

La entrada al programa se produce desde los diferentes servicios de emergencias (SAMUR Protección Civil, SAMUR Social, Bomberos, Policía, etc.), o derivados desde los Servicios Sociales de los distritos, Departamento de Servicios de Ayuda a Domicilio, Departamento de Centros de Día y Residenciales, Programa de Soledad y Programa "Cuidar a quienes Cuidan". Todos los casos que llegan son analizados por un equipo multidisciplinar que hace una valoración de riesgos a través del análisis de situación.

LA VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES: "CONOCER PARA ACTUAR".

Los datos de la Mesa permiten construir la **tasa de vulnerabilidad** (número de personas mayores valoradas en la Mesa de Vulnerabilidad sobre el total de personas mayores de cada distrito por mil) en los 21 distritos.

TRUJILLO FORMACIÓN

OBSERVATORIO DE FALLECIMIENTOS EN SOLEDAD Y EMERGENCIAS.

Uno de los objetivos específicos del "Programa de detección e intervención en mayores vulnerables con alto riesgo de aislamiento social", es la creación de un **sistema de monitorización de datos** a fin de:

- Conocer la magnitud del problema en términos absolutos.
- Conocer la distribución temporal (estacional) del fenómeno.
- Conocer la distribución espacial (distrital).
- Observar tendencias.

La Dirección General de Emergencias y Protección Civil nos informa de las aperturas de puerta en domicilio con resultado de fallecimiento. Esta información se complementa con el Padrón, CIVIS, información de visita al domicilio de la persona fallecida y el Registro Civil, lo que nos permite conocer su perfil. Uno de los datos más importantes es conocer hasta qué punto estos fallecimientos han ocurrido a personas aisladas socialmente o han obedecido a cualquier otra circunstancia, incluida la muerte súbita.

EQUIPOS DISTRITALES DE ATENCIÓN A LA VULNERABILIDAD.

Una de las medidas adoptadas en los Acuerdos de la Villa (Medida: MS.GT3.009/109) fue la creación de los Equipos Distritales de Atención a la Vulnerabilidad. Son equipos técnicos multidisciplinares para el abordaje de casos complejos de intervención con personas mayores, relacionados con el maltrato, la vulnerabilidad, la soledad, con un enfoque de detección precoz y prevención de situaciones no deseables.

Esta medida también se recoge en el II Plan de acción "Ciudades amigables con las personas mayores 2021-2023".

Se inició la puesta en marcha del proyecto piloto de los Equipos Distritales de Atención a la Vulnerabilidad (EDAV) en septiembre de 2021 en tres distritos: Villaverde, Arganzuela y Salamanca. Tras el análisis del proyecto piloto se valora en un futuro trasladar la iniciativa al resto de distritos con respectivas áreas de mejora.

La función de la mesa distrital es analizar los casos de personas mayores supuestamente vulnerables, en riesgo, detectadas por cualquiera de los agentes que operan en el distrito, buscar la mejor opción posible para revertir la situación y coordinar con los recursos que puedan ponerse a disposición de este propósito, en un intento de normalización y siempre respetando la autonomía de la persona mayor. Se exponen casos especialmente complejos, para lo cual se hace necesario tener unos criterios uniformes y previos, tanto en la relación del tipo de vulnerabilidad a abordar como de su severidad. Los casos graves y muy graves se abordarán en las mesas distritales, para encontrar la mejor intervención posible.

La mesa se compone de miembros permanentes e invitados, todos ellos involucrados en los casos que se valoran y que plantean objetivos comunes y una estrategia de intervención para el abordaje de las diferentes situaciones. En estos espacios de coordinación siempre participa personal técnico del servicio especializado de la Dirección General.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICA EN MALTRATO Y AISLAMIENTO SOCIAL.

Se trata de un servicio dirigido a personas vulnerables, en riesgo de sufrir maltrato, o en situación de soledad no deseada o aislamiento, mayores de 65 años, o de menor edad en casos excepcionales, y también a las personas que puedan estar implicadas en el posible maltrato, así como a su entorno cercano, familiares o amigos.

TRUJILLO FORMACIÓN

La determinación del grado de riesgo de aislamiento social y de la situación de riesgo y gravedad de los casos de malos tratos, tras una primera valoración desde la Mesa de vulnerabilidad de la Dirección General de Mayores, permite establecer un diagnóstico y pronóstico, y fijar unos objetivos. En función de ese riesgo, un equipo multidisciplinar de la Dirección General de Mayores propone la intervención del servicio de Apoyo Psicológico.

En el caso del aislamiento, se busca un acercamiento a las personas mayores con claro riesgo de aislamiento social, que permita conducir esas situaciones a la normalización, asignando los recursos sociales oportunos en cada caso y facilitando el internamiento involuntario y la incapacitación legal cuando la situación de riesgo así lo determine.

El programa de malos tratos implica un nivel de atención especializada con el carácter singular de intervención en el domicilio. El objetivo es la atención de las personas mayores víctimas de malos tratos en la ciudad de Madrid mediante un protocolo de actuación municipal que aborda la demanda de los distritos, canaliza recursos especializados y planifica las acciones para llevarlo a cabo. Para ello, se elabora un Plan de Intervención Individualizado que incluya a la persona mayor y al responsable con un diagnóstico de riesgos, decisiones de activar medidas de protección y reparación del maltrato coordinadamente.

El cierre de los casos en los que se realiza intervención se produce por normalización de la situación, tanto dentro del domicilio (aceptación de recursos, porque el supuesto responsable ya no reside en el domicilio o por la implementación de medidas legales de protección), como fuera del domicilio (ingreso voluntario/involuntario en residencia o traslado a otro domicilio).

Los casos atendidos en 2022 han sido de 146 (103 de maltrato/negligencia y 43 de aislamiento).

Cabe señalar que desde el servicio se atienden mujeres cuyo maltrato podría clasificarse como violencia machista por ser ejercido por su cónyuge/pareja. En este sentido, de los casos de maltrato trabajados desde 2009, se han abordado 348 casos con algún componente de violencia de género ejercido por hombres a mujeres mayores. De estos, en 107 casos el maltrato es ejercicio por el cónyuge/pareja, y los otros 241 casos es ejercido por hombres con algún otro tipo de relación. Estos casos se abordan desde el programa específico de maltrato a personas mayores dadas las características de estas mujeres que por cuyo perfil tienen dificultades de acceso a los recursos de la red de violencia de género.

TRUJILLO FORMACIÓN